AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

# REPASO FINAL

## DIABETES MELLITUS

Dislipidemias

**25** temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

# Índice

**Cómo usarlo.** Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.


## 01 Diagnóstico, Clasificación y Tamizaje de Diabetes

★★☆ 1.1. Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY GES ..... 3
★★★ 1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS GES ..... 4
★★★ 1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) GES ..... 5
★★★ 1.4. Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas GES ..... 6
★☆☆ 1.5. Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular GES ..... 7

## 02 Farmacoterapia Oral y Manejo de DM2 en APS

★★★ 2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL GES ..... 8
★★★ 2.2. Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas GES ..... 9
★★★ 2.3. Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 ..... 10
★★★ 2.4. Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante GES ..... 11
★☆☆ 2.5. Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal GES ..... 12

## 03 Insulinoterapia y Manejo Hospitalario

★★★ 3.1. Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio GES ..... 13
★★★ 3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis GES ..... 14
★★★ 3.3. Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado GES ..... 15
★★☆ 3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate GES ..... 16

## 04 Emergencias Hiperglicémicas Agudas

★★☆ 4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) GES ..... 17
★★☆ 4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH GES ..... 18
★★☆ 4.3. Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato GES ..... 19
★☆☆ 4.4. Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea GES ..... 20
★☆☆ 4.5. Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia GES ..... 21

## 05 Complicaciones Crónicas y Dislipidemias

★★☆ 5.1. Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector GES ..... 22
★☆☆ 5.2. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES GES ..... 23
★★☆ 5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico GES ..... 24
★★☆ 5.4. Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas GES ..... 26
★☆☆ 5.5. Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis GES ..... 27
★★☆ 5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria ..... 28

**Números que tienes que saber** 30
**Fármacos de primera línea** 33
**GES de la especialidad** 34
**Plan de repaso de 7 días** 36
**Índice por prioridad ★** 37

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

# 1.1 Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.004 **Diabetes Mellitus tipo 1** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**También:** Diabetes mellitus tipo 2

## LO QUE TE PREGUNTAN

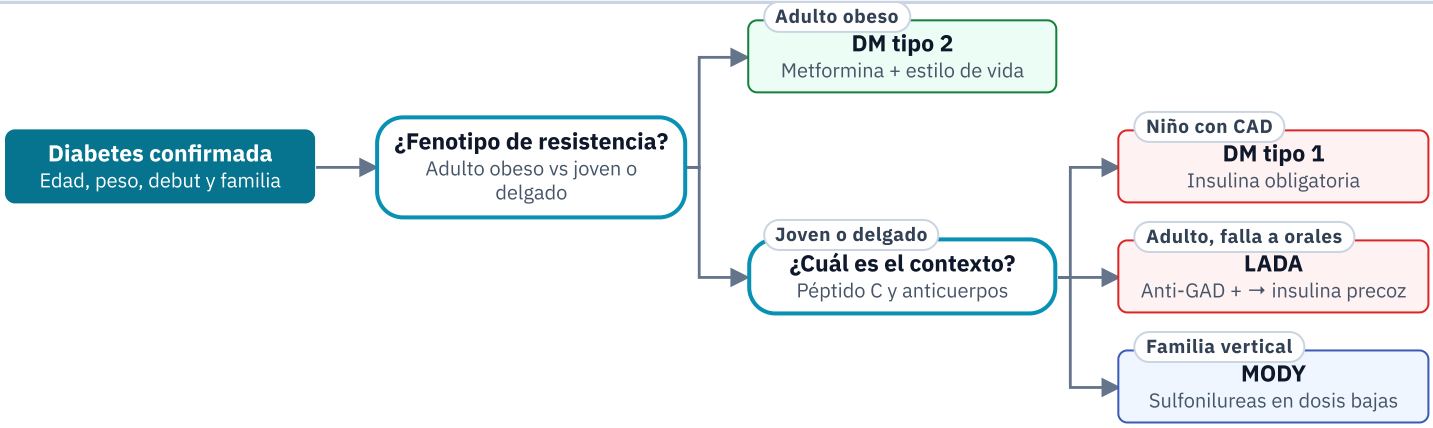
- La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.
- La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.
- **La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto**: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.
- La diabetes MODY es monogénica autosómica dominante (historia familiar vertical en delgados) y responde a sulfonilureas.
- El péptido C mide la producción endógena de insulina; permite diferenciar causas autoinmunes de resistencia a la insulina.



**ACANTOSIS EN EL CUELLO**
High-Yield review, p. 774

## ALGORITMO · TIPOS DE DIABETES: ¿LE QUEDA INSULINA AL PÁNCREAS?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 1.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DM TIPO 1, DM TIPO 2, LADA Y MODY

| CARACTERÍSTICA | DM TIPO 1 | DM TIPO 2 | LADA (ADULTO) | MODY (GENÉTICA) |
|---|---|---|---|---|
| **Edad habitual de debut** | < 20 años (niños/jóvenes) | > 35 - 45 años (adultos) | 25 a 50 años | < 25 años |
| **Hábito corporal / IMC** | Normopeso o bajo peso | Sobrepeso u Obesidad (> 85%) | Normopeso o leve sobrepeso | Delgado / Normopeso |
| **Herencia y antecedentes** | Poligénica / HLA-DR3-DR4 | Familiar poligénica alta | Autoinmunidad asociada | Autosómica dominante (3 gen.) |
| **Péptido C sérico** | Muy disminuido / Ausente | Elevado o normal | Bajo o descendiendo | Normal o detectable |
| **Anticuerpos (Anti-GAD)** | Positivos (> 85-90%) | Negativos | Positivos (patognomónico) | Negativos |
| **Respuesta inicial a HGO** | Nula (insulina obligatoria) | Buena (metformina) | Fracaso precoz a HGO | Excelente a Sulfonilureas |

## TRAMPAS EUNACOM

| TIPO | PERFIL CLÍNICO | LABORATORIO | TRATAMIENTO INICIAL |
|---|---|---|---|
| **DM tipo 1** | Menor de 20, normo o bajo peso, CAD | Péptido C ausente · anticuerpos + | Insulina obligatoria |
| **DM tipo 2** | Adulto con obesidad, acantosis | Péptido C normal o alto · anticuerpos – | Metformina + estilo de vida |
| **LADA** | Adulto 25–45, delgado, otra autoinmunidad | Anti-GAD + · péptido C en descenso | Insulina precoz |

**REGLA DE ORO** **Tipo 1: déficit absoluto** — Joven, flaco, cetosis: insulina

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **6–12** (pág. 9) · solucionario págs. 21–22.

**Clase 1.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

# 1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS

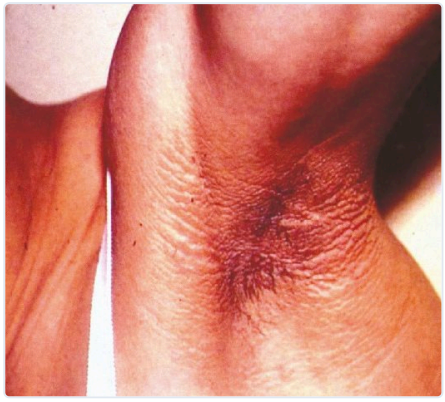
★★★ PRIORIDAD ALTA
21 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.005 **Diabetes mellitus tipo 2** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**También:** Test de tolerancia a la glucosa · Hemoglobina glicosilada · Glicemia venosa

## LO QUE TE PREGUNTAN

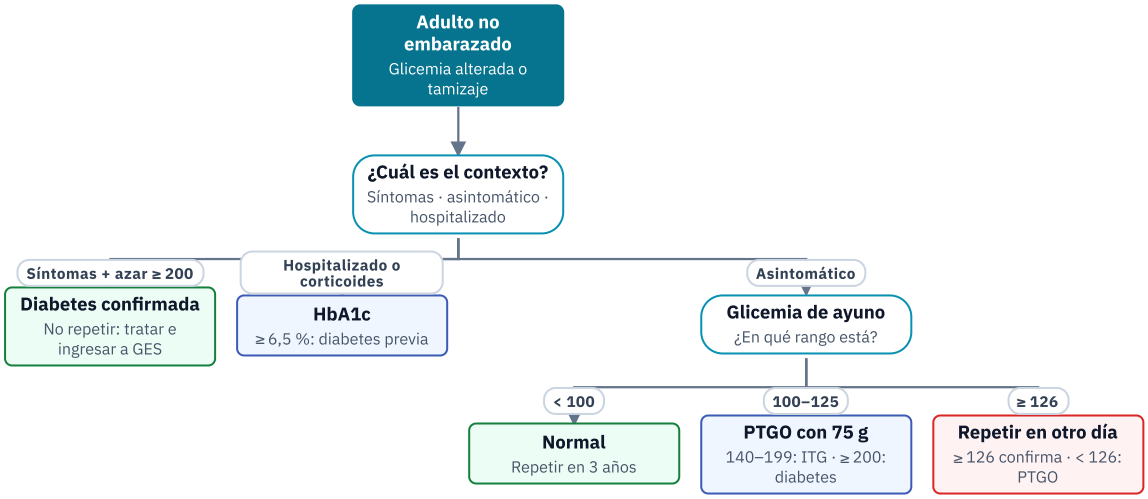
- **Cuatro criterios**: Ayuno **≥ 126 mg/dL**; PTGO **2h ≥ 200 mg/dL**; HbA1c **≥ 6.5%**; o Glicemia al azar **≥ 200 mg/dL** con síntomas.
- En pacientes asintomáticos, toda glicemia **≥ 126 mg/dL** DEBE repetirse en un día diferente para confirmar.
- Glicemia casual **≥ 200 mg/dL** con síntomas clásicos (4 P) confirma el diagnóstico sin requerir segundo examen.
- Glicemia de ayuno entre 100 y **125 mg/dL** se denomina Glicemia de Ayuno Alterada y exige solicitar una PTGO con **75 g**.
- La PTGO diagnostica Intolerancia a la Glucosa si el valor a las **2 horas** es **140–199 mg/dL**, y Diabetes si es **≥ 200 mg/dL**.



**ACANTOSIS NIGRICANS**
Manual AMIR Dermatología, p. 30

## ALGORITMO · DIAGNÓSTICO DE DIABETES EN EL ADULTO NO EMBARAZADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 1.2 · CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE HOMEOSTASIS GLUCÉMICA EN NO GESTANTES

| CATEGORÍA | GLICEMIA DE AYUNO (8H) | PTGO 75G (A LAS 2 HORAS) | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) |
|---|---|---|---|
| **Normal** | < 100 mg/dL | < 140 mg/dL | < 5.7% |
| **Glicemia de Ayuno Alterada (GAA)** | 100 a 125 mg/dL | < 140 mg/dL | 5.7% a 6.4% |
| **Intolerancia a la Glucosa Oral (ITG)** | < 100 o 100-125 mg/dL | 140 a 199 mg/dL | 5.7% a 6.4% |
| **Diabetes Mellitus** | ≥ 126 mg/dL (confirmada) | ≥ 200 mg/dL | ≥ 6.5% (confirmada) |
| **Crisis Hiperglicémica con Síntomas** | Cualquier glicemia al azar ≥ 200 mg/dL + Síntomas clásicos (No requiere repetición) | — | — |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Síntomas + glicemia al azar ≥ 200** | Diagnóstico confirmado: tratar | Pedir glicemia de ayuno para confirmar |
| **Asintomático, ayuno ≥ 126** | Repetir en otro día | Diagnosticar con un solo valor |
| **Ayuno 100–125** | PTGO con 75 g | Repetir la glicemia de ayuno |

**REGLA DE ORO** **Ayuno 126 · PTGO 200 · HbA1c 6,5 %** — O azar 200 con síntomas

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **13–16** (pág. 10) · solucionario págs. 22–23.

**Clase 1.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

# 1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

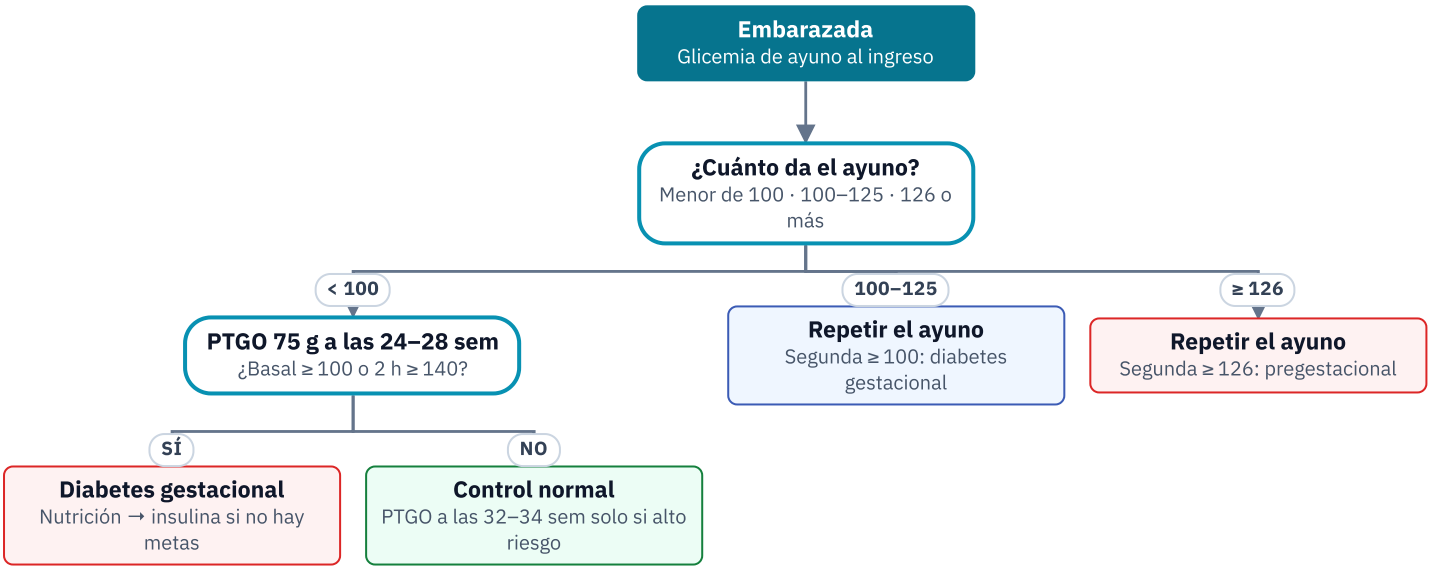
1.02.1.002 **Diabetes gestacional** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**También:** Diabetes mellitus pregestacional · Diabetes y embarazo · Test de tolerancia a la glucosa

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **En el embarazo NO existe la prediabetes**: cualquier glicemia de ayuno **≥ 100 mg/dL** confirmada es Diabetes Gestacional.
- Dos glicemias de ayuno **≥ 100 mg/dL** en cualquier momento del embarazo hacen el diagnóstico de Diabetes Gestacional.
- Si en las primeras **12 semanas** presenta glicemia de ayuno **≥ 126 mg/dL** confirmada, es Diabetes Pregestacional.
- La Diabetes Pregestacional aumenta el riesgo de malformaciones congénitas; la Diabetes Gestacional causa macrosomía y distocia.
- La PTGO de **75 g** se realiza universalmente entre las semanas 24 y 28; el corte a las **2 horas** es **≥ 140 mg/dL**.
- La PTGO se repite a las **32–34 semanas** solo si hay factores de alto riesgo: feto grande, polihidramnios o DMG previa.

## ALGORITMO · DIABETES EN EL EMBARAZO: EL MOMENTO Y EL VALOR




## TABLA 1.3 · COMPARACIÓN CLÍNICA: DIABETES GESTACIONAL VS DIABETES PREGESTACIONAL

| CARACTERÍSTICA | DIABETES GESTACIONAL (DMG) | DIABETES PREGESTACIONAL (DMPG) |
|---|---|---|
| **Momento de inicio / pesquisa** | Durante el embarazo (típicamente > 12 semanas) | Previa al embarazo o en primeras 12 semanas con glicemia ≥ 126 |
| **Riesgo de Malformaciones fetales** | NO aumentado (organogénesis ya completada) | ALTO RIESGO (cardiopatías conotruncales, regresión caudal) |
| **Complicaciones fetales típicas** | Macrosomía, polihidramnios, distocia de hombros | Malformaciones, RCIU por daño vascular, muerte in utero |
| **Criterio diagnóstico en ayuno** | ≥ 100 mg/dL en 2 ocasiones | ≥ 126 mg/dL en 2 ocasiones (o diagnóstico previo) |
| **PTGO 75g a las 2 horas** | ≥ 140 mg/dL | ≥ 200 mg/dL |
| **Conducta postparto** | PTGO con 75 g a las 6-12 semanas postparto | Mantener insulinoterapia según requerimiento crónico |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| CARACTERÍSTICA | DIABETES GESTACIONAL | DIABETES PREGESTACIONAL |
|---|---|---|
| **Después del parto** | PTGO a las 6–12 semanas | Mantener su tratamiento |

**REGLA DE ORO** **No existe la prediabetes** — Ayuno ≥ 100 · PTGO 2 h ≥ 140

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, pregunta **17** (pág. 10) · solucionario pág. 23.

**Clase 1.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

# 1.4 Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

*Alta · Metas individualizadas en adultos mayores vs jóvenes y costo de la hipoglicemia*

1.02.1.005
1.07.1.005
**Diabetes mellitus tipo 2**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

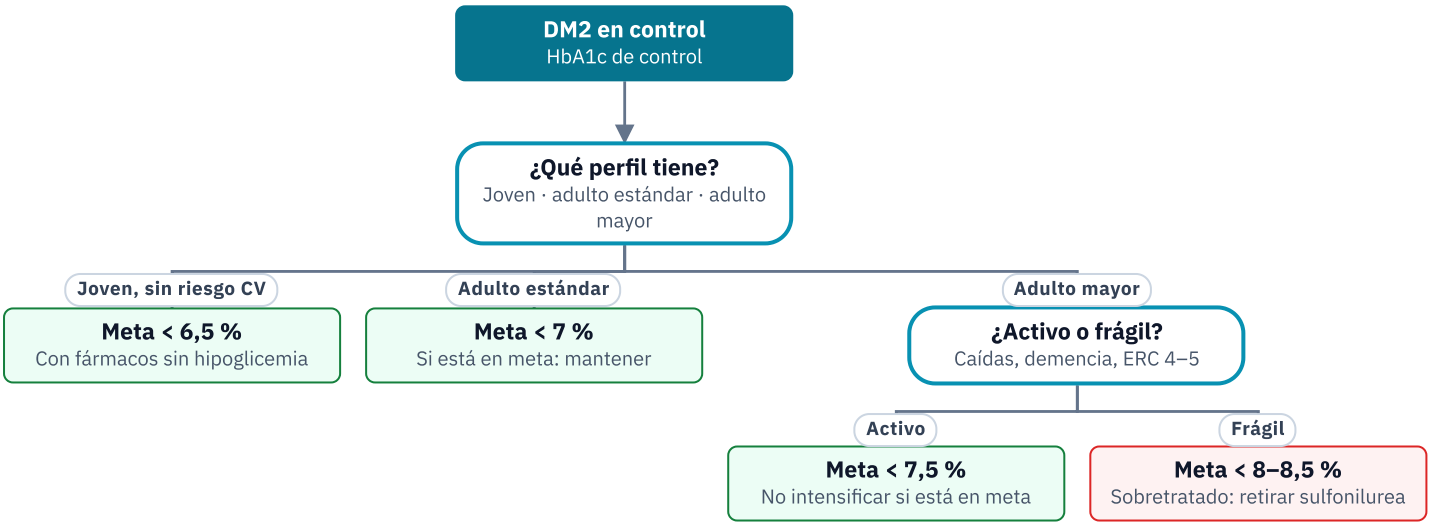
**También:** Hemoglobina glicosilada · Prevención de complicaciones crónicas de la diabetes

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Meta estándar de HbA1c para la mayoría de los adultos con DM2**: < **7.0%** (glicemia preprandial **80–130 mg/dL**).
- El estudio ACCORD demostró que un control hiper-estricto (< **6.0%**) en diabéticos con comorbilidad aumenta la mortalidad.
- En adultos mayores frágiles, con demencia o ERC avanzada, la meta se flexibiliza a HbA1c < **8.0%–8.5%**.
- Si un adulto mayor tiene HbA1c bajo **8.0%** y no tiene síntomas de descompensación, NO se debe subir el tratamiento.
- La meta de presión arterial en diabetes es < 130/**80 mmHg** y el colesterol LDL debe ser < **70 mg/dL** (o < 55 en daño de órgano).

## ALGORITMO · METAS DE HBA1C: ¿QUIÉN ES EL PACIENTE?

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción




## TABLA 1.4 · INDIVIDUALIZACIÓN DE METAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (ADA / MINSAL)

| PERFIL CLÍNICO DEL PACIENTE | META DE HBA1C | GLICEMIA PREPRANDIAL | GLICEMIA POSTPRANDIAL (2H) |
|---|---|---|---|
| **Joven, diagnóstico reciente, sin complicaciones** | < 6.5% - 7.0% | 80 a 130 mg/dL | < 180 mg/dL |
| **Adulto estándar con DM2 y expectativa > 15 años** | < 7.0% | 80 a 130 mg/dL | < 180 mg/dL |
| **Adulto mayor activo, comorbilidad leve** | < 7.5% | 90 a 140 mg/dL | < 180-200 mg/dL |
| **Adulto mayor frágil, demencia, ERC 4-5 o hipoglicemias** | < 8.0% - 8.5% | 100 a 150 mg/dL | < 200 mg/dL |
| **Mujer embarazada con Diabetes Gestacional** | < 6.0% (sin hipoglicemia) | < 90-95 mg/dL | < 120 mg/dL |

**REGLA DE ORO** **Estándar < 7 % · joven < 6,5 %** — Estricto solo sin riesgo de hipoglicemia

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 23.

**Clase 1.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

# 1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

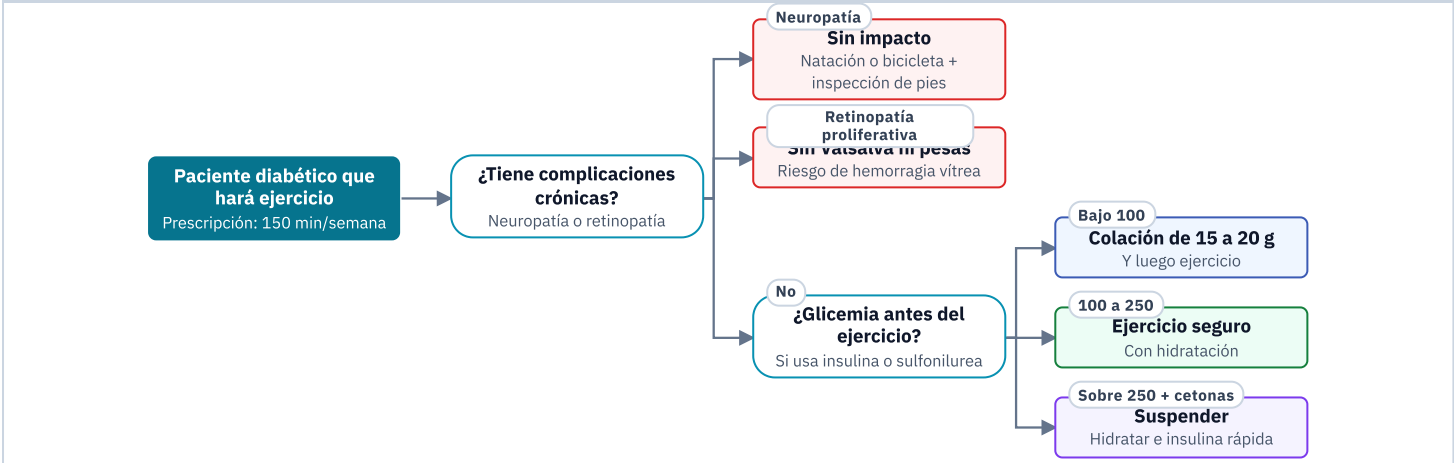
**1.02.3.004** **Estilos de vida saludables (hábitos y conductas)** — Conocimiento general

**También:** Diabetes y riesgo cardiovascular · Hipoglicemias · Estrategias de control de enfermedades crónicas prioritarias (cáncer, cardiovasculares) · Sedentarismo vs actividad física · Test de esfuerzo

## LO QUE TE PREGUNTAN

- El ejercicio estimula la captación de glucosa por translocación de GLUT-4 vía AMPK independiente de la insulina.
- La recomendación universal es de al menos **150 minutos** semanales de ejercicio aeróbico moderado repartido en **≥ 3 días**.
- En usuarios de insulina o sulfonilureas, si la glicemia pre-ejercicio es < **100 mg/dL**, se debe consumir **15-20 g** de carbohidratos.
- El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina hasta por **24-48 horas**, pudiendo generar hipoglicemias nocturnas tardías.
- En pacientes con neuropatía diabética periférica se deben preferir actividades sin impacto (bicicleta, natación) e inspeccionar los pies.

## ALGORITMO · EJERCICIO SEGURO EN EL PACIENTE CON DIABETES




## TABLA 1.5 · PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO Y RECOMENDACIONES GLUCÉMICAS EN DIABETES

| SITUACIÓN CLÍNICA | NIVEL DE GLICEMIA PRE-ESFUERZO | CONDUCTA RECOMENDADA | FÁRMACOS DE ALTO RIESGO |
|---|---|---|---|
| **Pre-ejercicio con hipoglicemia latente** | < 100 mg/dL | Ingerir 15 a 20 g de hidratos de carbono antes de iniciar | Insulina NPH/Cristalina, Glibenclamida |
| **Pre-ejercicio en rango seguro** | 100 a 250 mg/dL | Iniciar ejercicio aeróbico con hidratación adecuada | Cualquiera |
| **Pre-ejercicio con hiperglicemia y cetonas** | > 250 mg/dL con cetonuria (+) | Suspender ejercicio; hidratar y administrar insulina rápida | Diabetes Mellitus Tipo 1 |
| **Presencia de neuropatía sensitiva de pies** | Indiferente | Evitar trote de impacto; preferir natación o bicicleta | Inspección de pies post-esfuerzo |
| **Retinopatía proliferativa activa** | Indiferente | Evitar pesas pesadas, saltos o maniobras de Valsalva | Riesgo de hemorragia vítrea |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Prescripción general** | 150 min/semana aeróbico moderado, ≥ 3 días | Dejar más de 2 días seguidos sin ejercicio |
| **Insulina o glibenclamida, glicemia < 100 mg/dL** | Colación de 15 a 20 g de carbohidratos y luego ejercicio | Suspender el ejercicio o salir igual |
| **Glicemia 100 a 250 mg/dL** | Ejercicio con hidratación | Pedir exámenes antes |

**REGLA DE ORO** **GLUT-4 sin insulina** — Sensibilidad aumentada 24 a 48 horas

**PRACTICA** Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Diabetes Mellitus**: usa las preguntas de la clase (QR).

**Clase 1.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

# 2.1 Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

*Máxima · Escalamiento de metformina a biterapia y criterios de inicio de insulina*

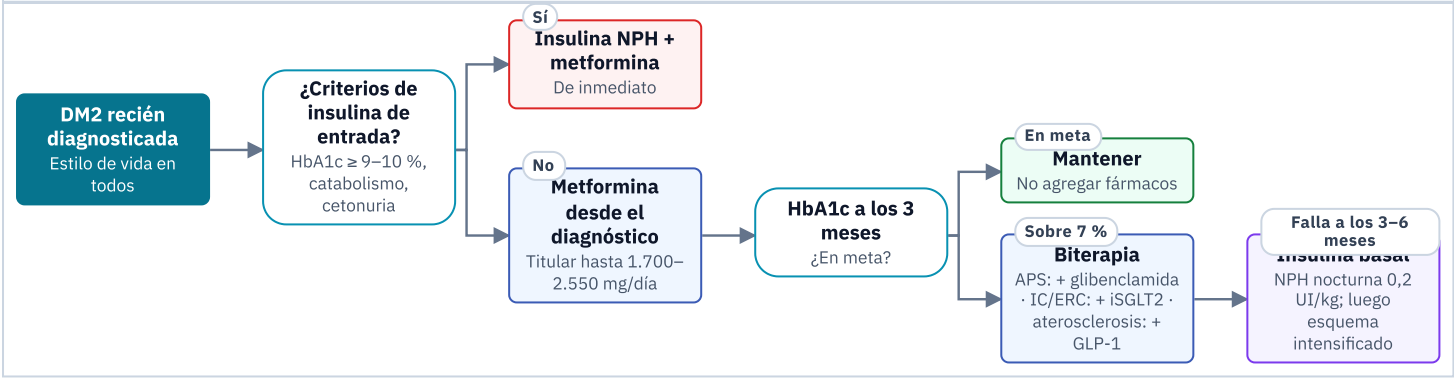
1.02.1.005 **Diabetes mellitus tipo 2** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**También:** Hemoglobina glicosilada

## LO QUE TE PREGUNTAN

- La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.
- La dosis terapéutica óptima de metformina es de **1.700 a 2.550 mg**/día (habitualmente **850 mg** c/**12h** o c/**8h**).
- Si a los **3 meses** de monoterapia la HbA1c es > **7.0%**, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.
- En APS la biterapia se realiza asociando glibenclamida (o iDPP4/iSGLT2 si están disponibles).
- **Criterios de inicio inmediato de insulina**: HbA1c **≥ 9.0-10.0%**, baja de peso rápida, cetonuria o descompensación aguda.
- La garantía GES N° 2 exige iniciar tratamiento farmacológico dentro de las **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.
- En pacientes con insuficiencia cardíaca o nefropatía, los iSGLT2 son el segundo fármaco de elección indiscutido.

## ALGORITMO · TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA DIABETES TIPO 2




## TABLA 2.1 · ESQUEMA DE ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO EN DIABETES TIPO 2 (GUÍAS MINSAL)

| NIVEL DE HBA1C | CONDUCTA INICIAL RECOMENDADA | FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA | ALTERNATIVA / ESCALAMIENTO |
|---|---|---|---|
| **HbA1c < 8.0%** | Monoterapia oral + Estilo de vida | Metformina 850 mg c/12h con comidas | Reevaluar a los 3 meses; si > 7% sumar 2° fármaco |
| **HbA1c 8.0% a 9.0%** | Monoterapia máxima o Biterapia precoz | Metformina 1.700 a 2.550 mg/día | Asociar Glibenclamida 5 mg/d o iDPP4 / iSGLT2 |
| **HbA1c ≥ 9.0% asintomático** | Biterapia oral directa obligatoria | Metformina + Segundo fármaco oral | Monitoreo en 30 a 60 días para evaluar respuesta |
| **HbA1c ≥ 9.0% + Baja de peso / Síntomas** | Insulinoterapia inmediata obligatoria | Insulina NPH nocturna (0.2-0.3 UI/kg) + Metformina | Ajuste semanal de insulina según glicemia matinal |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **DM2 recién diagnosticada, sin síntomas** | Estilo de vida + metformina desde el inicio | Meses de "prueba de dieta" |
| **DM2 con IC o ERC** | Agregar iSGLT2 | Pioglitazona en la IC |
| **Falla de biterapia a dosis máxima** | Iniciar insulina basal | Subir más los orales |
| **Plazos GES** | Confirmar en 45 días; tratar en 24 h | Confundir los dos plazos |

**REGLA DE ORO** **Metformina desde el diagnóstico** — Junto con el estilo de vida

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **19–23** (págs. 10–11) · solucionario págs. 23–24.

**Clase 2.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

# 2.2 Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2 — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

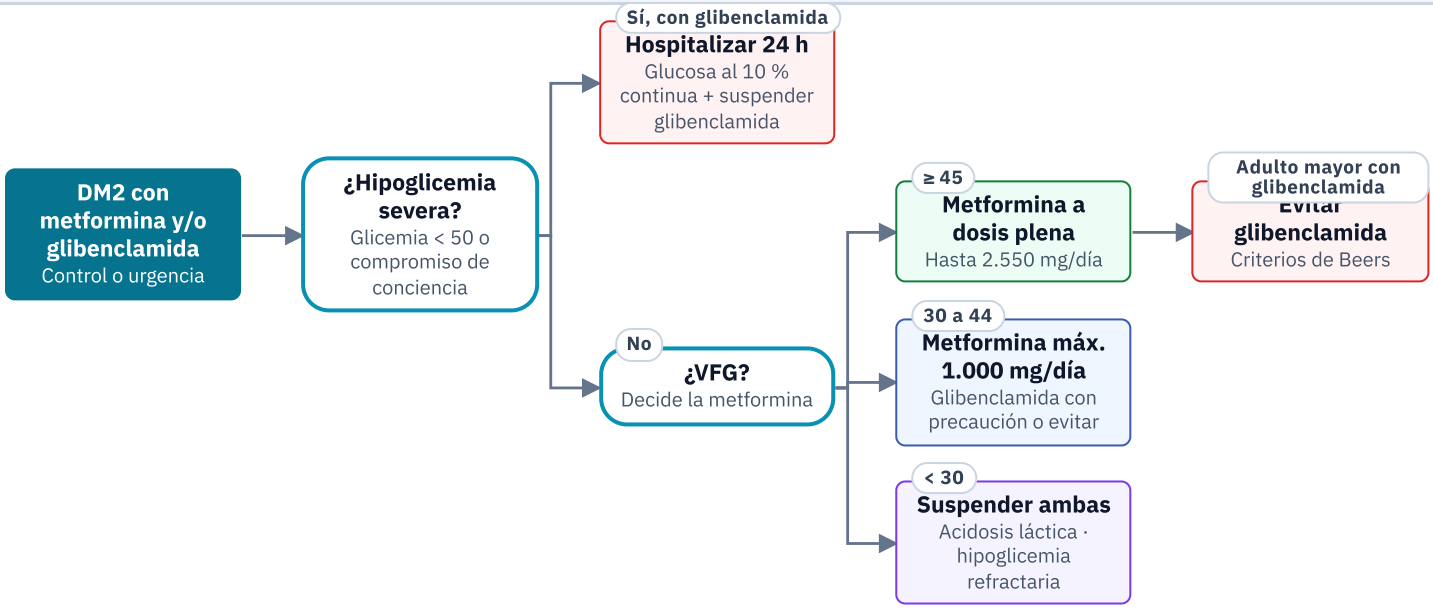
**También:** Hipoglicemias · Acidosis láctica

## LO QUE TE PREGUNTAN

- La metformina reduce la producción hepática de glucosa vía activación de la AMPK; no causa hipoglicemia en monoterapia.
- La metformina está formalmente contraindicada si la VFG es < **30 mL**/min/1.73m² por riesgo de acidosis láctica.
- Si la VFG está entre 30 y **44 mL**/min, la dosis máxima de metformina debe reducirse a **1.000 mg**/día.
- La glibenclamida es un secretagogo que estimula la liberación de insulina independiente de la glicemia plasmática.
- La glibenclamida está contraindicada en adultos mayores y nefrópatas por riesgo de hipoglicemias letales prolongadas.
- Toda hipoglicemia severa por glibenclamida exige hospitalización en observación con suero glucosado continuo por **24 horas**.

## ALGORITMO · METFORMINA Y GLIBENCLAMIDA: SEGURIDAD

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 2.2 · COMPARACIÓN FARMACOLÓGICA: METFORMINA VS GLIBENCLAMIDA

| PARÁMETRO | METFORMINA (BIGUANIDA) | GLIBENCLAMIDA (SULFONILUREA) |
|---|---|---|
| **Mecanismo de acción** | Inhibe gluconeogénesis hepática (vía AMPK) | Secretagogo: cierra canales K-ATP en célula beta |
| **Riesgo de hipoglicemia** | NULO en monoterapia | ALTO RIESGO (prolongada y grave) |
| **Efecto sobre el peso** | Neutro o modesta baja de peso (1-2 kg) | Aumento de peso (2 a 4 kg) |
| **Ajuste renal (VFG 30-44)** | Reducir dosis a máximo 1.000 mg/día | Usar con precaución o evitar |
| **Ajuste renal (VFG < 30)** | CONTRAINDICADA (Acidosis láctica) | CONTRAINDICADA (Hipoglicemia refractaria) |
| **Uso en Adulto Mayor** | De elección si la función renal es segura | DESACONSEJADA / EVITAR (Criterios Beers) |
| **Efecto secundario cardinal** | Gastrointestinal (diarrea, náuseas, meteorismo) | Hipoglicemia sintomática grave |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| PARÁMETRO | METFORMINA | GLIBENCLAMIDA |
|---|---|---|
| **Usuario de metformina con falla renal aguda o sepsis, vómitos y Kussmaul** | Lactato alto, cetonas negativas: suspender y derivar | Tratarla como cetoacidosis |

**REGLA DE ORO** **Frena al hígado, sin hipoglicemia** — Vía AMPK

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **24–25** (pág. 11) · solucionario pág. 24.

**Clase 2.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

# 2.3 Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4

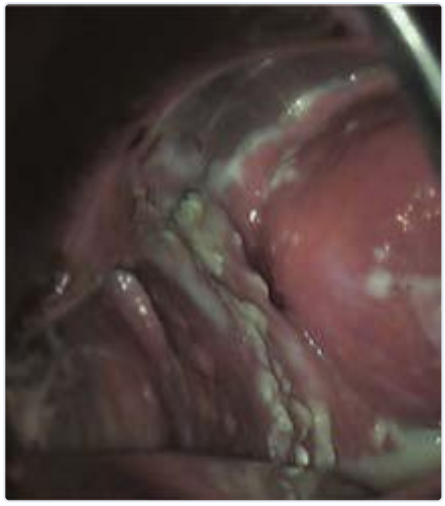
★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2 — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**También:** Diabetes y riesgo cardiovascular

## LO QUE TE PREGUNTAN

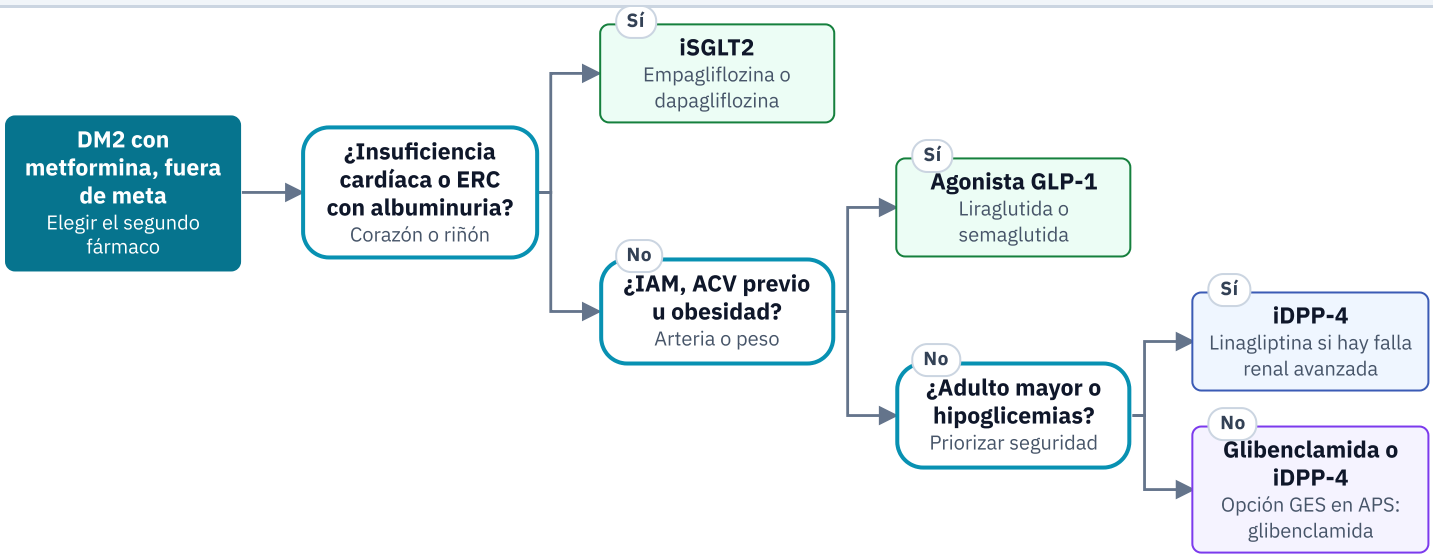
- Los inhibidores SGLT2 bloquean la reabsorción tubular proximal de glucosa induciendo glucosuria protectora.
- Los iSGLT2 reducen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frenan la progresión de la enfermedad renal crónica.
- El efecto adverso más común de los iSGLT2 son las infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal y balanitis).
- **Riesgo grave de iSGLT2**: Cetoacidosis Diabética Euglicémica ante situaciones de estrés quirúrgico o ayuno prolongado.
- Los agonistas de GLP-1 inducen marcada saciedad y baja de peso, reduciendo eventos ateroscleróticos mayores (IAM, ACV).
- La linagliptina (iDPP-4) tiene eliminación biliar y NO requiere ajuste de dosis en falla renal avanzada.



**CANDIDIASIS VAGINAL**
Kumar and Clark, Clinical Medicine, p. 1587

## ALGORITMO · SEGUNDO FÁRMACO SEGÚN EL ÓRGANO DIANA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción




## TABLA 2.3 · CUADRO COMPARATIVO: ISGLT2 VS AGONISTAS GLP-1 VS IDPP-4

| FAMILIA | MECANISMO PRIMARIO | IMPACTO EN PESO | BENEFICIO ÓRGANO BLANCO | EFECTO ADVERSO SELLO |
|---|---|---|---|---|
| **iSGLT2 (Gliflozinas)** | Glucosuria tubular proximal | Baja 2 a 3 kg | Insuficiencia cardíaca y Nefroprotección | Micosis genitales y CAD euglicémica |
| **GLP-1 RA (Incretinas)** | Receptor GLP-1 (saciedad/incretina) | Baja 5 a 15 kg | Enfermedad coronaria aterosclerótica y ACV | Náuseas y vómitos al titular |
| **iDPP-4 (Gliptinas)** | Inhibe degradación de GLP-1 | Neutro | Seguridad global; sin hipoglicemias | Raro: pancreatitis aguda |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| FAMILIA | BENEFICIO QUE SE PREGUNTA | EFECTO ADVERSO SELLO | PESO |
|---|---|---|---|
| **Linagliptina** | Sin ajuste en ninguna falla renal | Eliminación biliar | Neutro |

**REGLA DE ORO** — **IC y ERC con albuminuria** — Glucosuria, sin hipoglicemia

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **26–27** (págs. 11–12) · solucionario pág. 24.

**Clase 2.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

# 2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

*Alta · Criterios estrictos de inicio de insulina y contraindicación de sulfonilureas*

1.02.1.002 **Diabetes gestacional** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

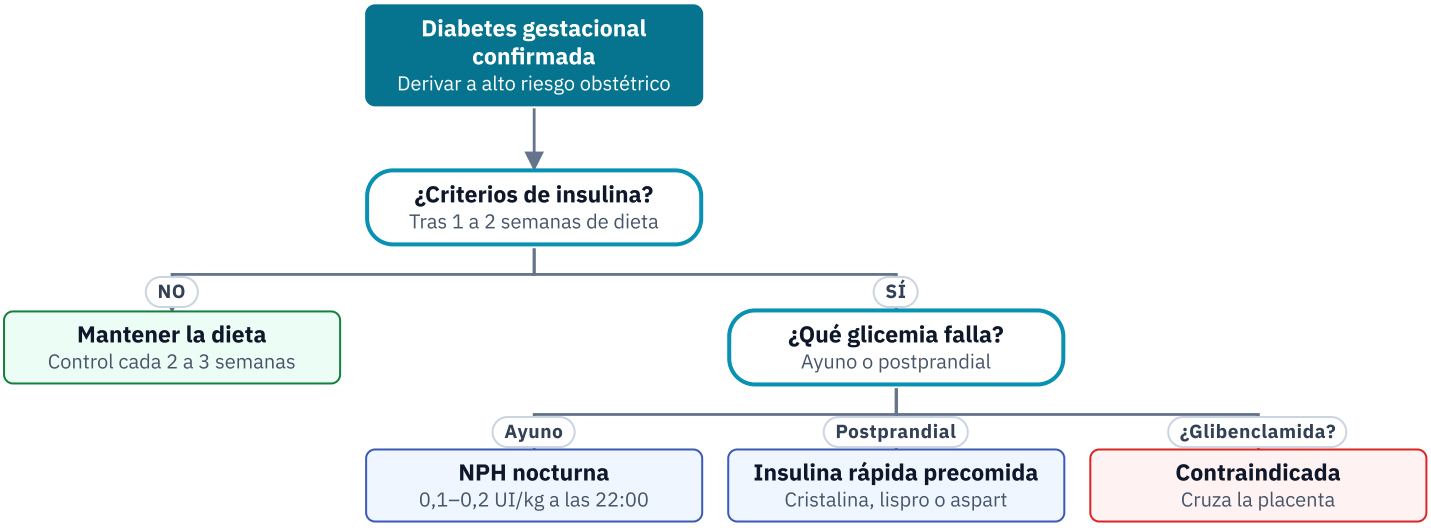
**También:** Diabetes mellitus pregestacional · Diabetes y embarazo · Glicemia capilar

## LO QUE TE PREGUNTAN

- El **70-80%** de las pacientes con diabetes gestacional se controla eficazmente solo con dieta fraccionada.
- El periodo de prueba de la dieta es de **1 a 2 semanas** con automonitoreo de 4 a 6 controles capilares al día.
- Si más del **20%** de los controles superan las metas (ayuno > 90-95 o **1h** post > 140), se debe iniciar insulina.
- La circunferencia abdominal fetal ≥ percentil 75-90 en ecografía es indicación de iniciar insulina precozmente.
- La insulina NPH y cristalina son los fármacos de elección indiscutidos; no cruzan la barrera placentaria.
- La glibenclamida está formalmente contraindicada por cruzar la placenta y provocar hipoglicemia neonatal severa.

## ALGORITMO · DIABETES GESTACIONAL: DE LA DIETA A LA INSULINA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 2.4 · MONITOREO Y METAS TERAPÉUTICAS EN DIABETES GESTACIONAL (MINSAL)

| MOMENTO DE MEDICIÓN | META GLUCÉMICA CAPILAR | FÁRMACO DE RESCATE SI FALLA | OBSERVACIÓN CLÍNICA |
|---|---|---|---|
| **Glicemia en ayunas (pre-desayuno)** | 70 a 90 - 95 mg/dL | Insulina NPH a las 22:00 h | Evalúa secreción basal nocturna materna |
| **Glicemia 1 hora postprandial** | < 140 mg/dL | Insulina Cristalina o Lispro precomida | Peak de glucosa en el embarazo |
| **Glicemia 2 horas postprandial** | < 120 mg/dL | Insulina Cristalina precomida | Alternativa si no se mide a la hora |
| **Glicemia nocturna (03:00 AM)** | > 60 mg/dL | Disminuir NPH o sumar colación | Descartar hipoglicemias nocturnas inadvertidas |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| MOMENTO | META | SI FALLA |
|---|---|---|
| **Falla de la dieta** | Insulina | Glibenclamida: prohibida |

**REGLA DE ORO** **Controla al 70–80 %** — Fraccionada, nunca bajo 1.500 kcal

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **28–29** (pág. 12) · solucionario pág. 25.

**Clase 2.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

# 2.5 Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

`1.02.1.008` **Hipertensión arterial en diabetes tipo 2** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

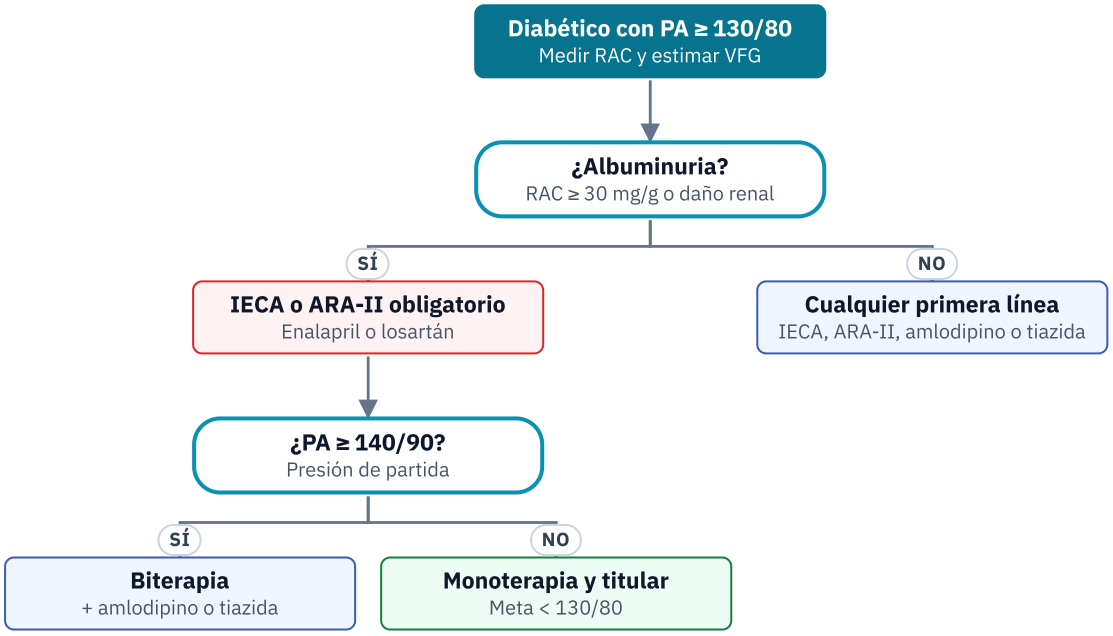
**También:** Nefropatía incipiente

## LO QUE TE PREGUNTAN

- La meta de presión arterial universal en pacientes diabéticos es < 130/**80 mmHg**.
- En diabéticos con albuminuria (RAC **≥ 30 mg/g**), los fármacos de primera línea obligatorios son IECA o ARA-II.
- **Mecanismo nefroprotector**: vasodilatación selectiva de la arteriola eferente que reduce la presión intraglomerular.
- Está formalmente contraindicado combinar un IECA con un ARA-II por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia.
- Si la PA basal es **≥ 140/90 mmHg** se recomienda iniciar biterapia asociando IECA/ARA-II con Amlodipino.
- Los betabloqueadores no son de primera línea en HTA pura en DM salvo indicación cardiológica (IAM o IC).

## ALGORITMO · HIPERTENSIÓN EN EL DIABÉTICO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción




## TABLA 2.5 · ESTRATEGIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA EN EL PACIENTE DIABÉTICO

| CONDICIÓN RENAL | FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA | FÁRMACO PARA BITERAPIA | META TENSIONAL |
|---|---|---|---|
| **Diabético con Albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g)** | IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán) | Calcioantagonista (Amlodipino) | < 130/80 mmHg |
| **Diabético sin Albuminuria (RAC < 30 mg/g)** | Cualquiera: IECA, ARA-II, Amlodipino o Tiazida | Combinación de dos clases principales | < 130/80 mmHg |
| **Diabético con Cardiopatía Coronaria previa** | IECA/ARA-II + Betabloqueador cardioselectivo (Atenolol/Bisoprolol) | Amlodipino | < 130/80 mmHg |
| **Diabético con VFG < 30 mL/min** | IECA/ARA-II con monitoreo estricto de Potasio | Diurético de asa (Furosemida) o Amlodipino | < 130/80 mmHg |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **PA ≥ 140/90 al inicio** | Biterapia: IECA o ARA-II + amlodipino | Monoterapia y esperar |
| **Proteinuria que persiste** | Optimizar un solo bloqueador | Sumar IECA + ARA-II |
| **Ya usa tiazida y atenolol, con proteinuria** | Agregar IECA | Mantener o cambiar el diurético |

**REGLA DE ORO** **PA < 130/80 mmHg** — Biterapia si parte ≥ 140/90

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **30–36** (págs. 12–13) · solucionario págs. 25–26.

**Clase 2.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

# 3.1 Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.005 **Diabetes mellitus tipo 2** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**También:** Diabetes Mellitus tipo 1

## LO QUE TE PREGUNTAN

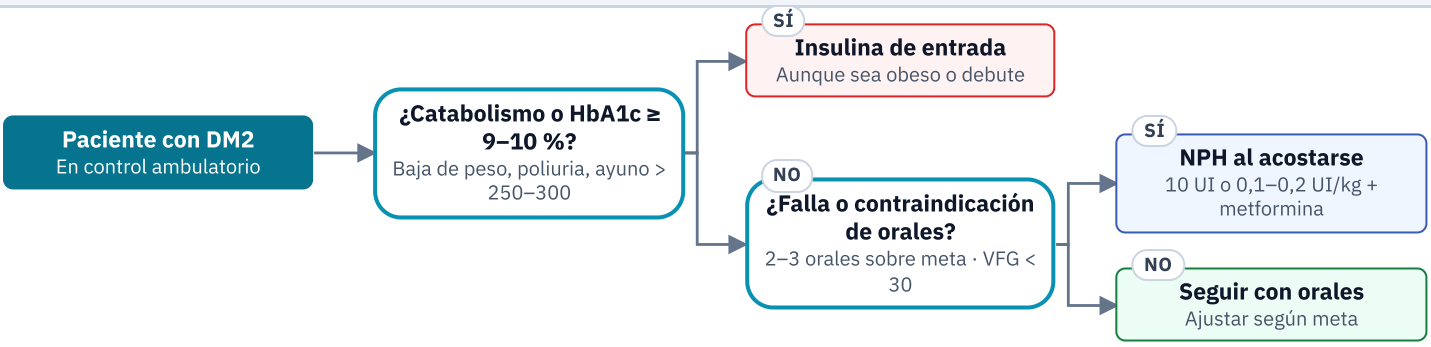
- La insulina NPH tiene un pico a las **4–10 horas**; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al acostarse (bedtime, 22:00–23:**00 hrs**).
- Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en **10-15 minutos** y se administran inmediatamente antes de comer; la cristalina requiere **30 minutos** de anticipación.
- La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética, perioperatorio, UCI).
- La lipohipertrofia por no rotar sitios de inyección produce absorción errática, hiperglicemias inexplicables y falsas sospechas de resistencia insulínica.
- En DM2 con HbA1c **≥ 9.0–10.0%** y síntomas catabólicos (baja de peso, polidipsia), la indicación directa es iniciar insulinoterapia, sin insistir en más fármacos orales.
- En insuficiencia renal avanzada (VFG < **30 ml**/min), la metformina está contraindicada y la insulina se convierte en el fármaco hipoglucemiante más seguro.



**LIPOHIPERTROFIA ABDOMINAL**
Open-i (NLM), CC BY

## ALGORITMO · DM2: ¿CUÁNDO SE INICIA INSULINA?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 3.1 · COMPARACIÓN FARMACOCINÉTICA DE LAS PRINCIPALES FORMULACIONES DE INSULINA

| TIPO DE INSULINA | FÁRMACOS REPRESENTATIVOS | INICIO DE ACCIÓN | PICO MÁXIMO | DURACIÓN EFECTIVA | MOMENTO DE INYECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultrarrápida (Análogo)** | Aspart, Lispro, Glulisina | 10 – 15 minutos | 1 – 2 horas | 3 – 5 horas | 0 a 15 min antes de comer (o justo después) |
| **Rápida (Humana regular)** | Cristalina / Regular | 30 – 60 minutos | 2 – 3 horas | 6 – 8 horas | 30 minutos antes de la comida principal |
| **Intermedia (Humana NPH)** | NPH (Isófana) | 1 – 2 horas | 4 – 10 horas (marcado) | 12 – 18 horas | Al acostarse (bedtime, 22-23h) o c/12h |
| **Prolongada (Análogo)** | Glargina U100, Detemir | 1 – 2 horas | Sin pico (plano) | 20 – 24 horas | 1 vez al día, a la misma hora |
| **Ultraprolongada (Análogo)** | Degludec, Glargina U300 | 30 – 90 minutos | Sin pico (ultraplano) | > 24 a 42 horas | 1 vez al día (mayor flexibilidad horaria) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| INSULINA | INICIO · PEAK · DURACIÓN | CUÁNDO SE INYECTA |
|---|---|---|
| **Cristalina (regular)** | 30–60 min · 2–3 h · 6–8 h | 30 min antes de comer; también EV |

**REGLA DE ORO** — **NPH: peak 4–10 h** — Siempre al acostarse

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **37–39** (pág. 13) · solucionario pág. 26.

**Clase 3.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

# 3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2 — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**También:** Diabetes Mellitus tipo 1 · Hipoglicemias · Glicemia capilar

## LO QUE TE PREGUNTAN

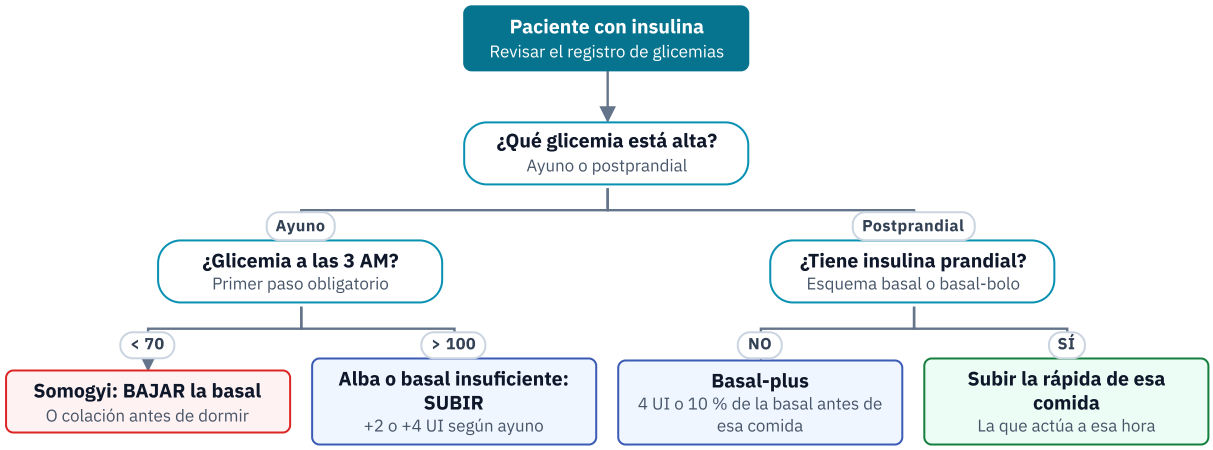
- **La regla de oro del ajuste prandial**: la glicemia elevada tras una comida se corrige modificando la dosis de insulina rápida previa a ESA comida específica.
- Ante una hiperglicemia matinal inexplicable, el primer paso clínico OBLIGATORIO es solicitar una glicemia capilar a las 03:00 AM para descartar Somogyi.
- **Si a las 03**:00 AM la glicemia es < **70 mg/dL**, es Efecto Somogyi y la conducta es REDUCIR la insulina nocturna; si es > **100 mg/dL**, es Fenómeno del Alba y se debe SUBIR.
- El esquema basal bedtime consiste en NPH **10 UI** o **0.1-0.2 UI**/kg a las 22:00-23:**00 hrs** manteniendo metformina oral.
- Los ajustes de insulina basal ambulatoria se realizan cada **3 a 7 días** en escalones de +**2 UI** (si **130-180 mg/dL**) o +**4 UI** (si > **180 mg/dL**).



**LIPOHIPERTROFIA ABDOMINAL**
Open-i (NLM), CC BY

## ALGORITMO · AJUSTE DE INSULINA: QUÉ GLICEMIA FALLA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción




## TABLA 3.2 · COMPARACIÓN ENTRE ESQUEMAS DE INSULINOTERAPIA EN DIABETES MELLITUS

| ESQUEMA | COMPONENTES | POBLACIÓN OBJETIVO | MONITOREO REQUERIDO | RIESGO HIPOGLICEMIA |
|---|---|---|---|---|
| **Basal Bedtime** | NPH 10 UI o Glargina al acostarse + Metformina oral | DM2 que no responde a terapia oral combinada | Glicemia capilar matinal en ayunas | Bajo a moderado |
| **Basal-Plus** | Basal nocturna + 1 bolo prandial (almuerzo o comida principal) | DM2 con ayuno en meta pero HbA1c > 7.0% | Ayuno + postprandial de la comida intervenida | Moderado |
| **Basal-Bolo Intensificado** | 1-2 basales (NPH c/12h o Glargina) + 3 bolos prandiales | Todos los DM1 y DM2 con déficit insulínico severo | Monitoreo 4-6 veces/día (pre y postcomidas) | Alto (requiere educación estricta) |
| **Bifásico (Mezclas fijas)** | Premezcla NPH/Cristalina (70/30) 2 veces/día con desayuno y cena | DM2 con horarios de comida muy regulares y baja adherencia a múltiples punciones | Pre-desayuno y pre-cena | Moderado-alto (poca flexibilidad horaria) |

## TRAMPAS EUNACOM

| CUADRO | GLICEMIA 3 AM | CONDUCTA | ERROR TÍPICO |
|---|---|---|---|
| **Efecto Somogyi** | < 70 mg/dL | BAJAR la basal o colación nocturna | Subir la insulina nocturna |
| **Fenómeno del alba** | > 100 mg/dL | SUBIR la basal o retrasarla al acostarse | Bajar la insulina nocturna |
| **Basal insuficiente** | > 140 mg/dL | Subir la basal o fraccionar la NPH | Agregar rápida nocturna |

**REGLA DE ORO** — **NPH bedtime + metformina** — Titular con el ayuno cada 3 a 7 días

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **40–43** (págs. 13–14) · solucionario págs. 26–27.

**Clase 3.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

# 3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado

★★★ PRIORIDAD ALTA
24 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2 — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

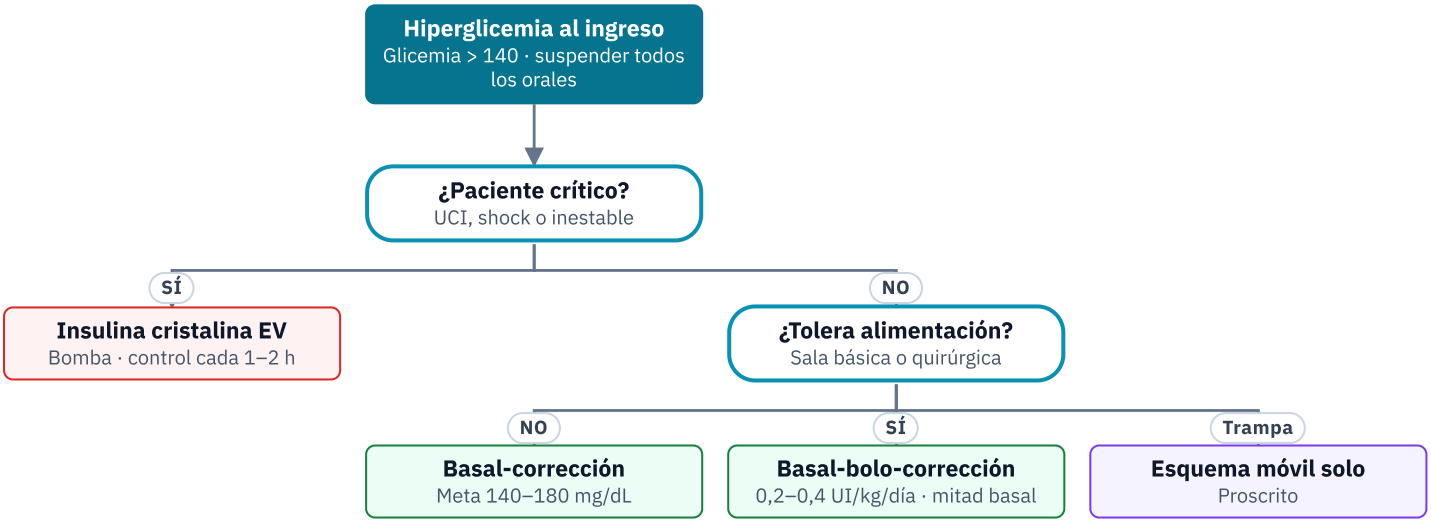
**También:** Glicemia capilar · Diabetes por corticoides

## LO QUE TE PREGUNTAN

- La meta de glicemia en el paciente hospitalizado (crítico y no crítico) es universalmente **140 – 180 mg/dL** (7.8 – 10.0 mmol/L).
- Metas estrictas (< **110 mg/dL**) en hospitalizados aumentan la mortalidad por hipoglicemia severa (evidencia del ensayo NICE-SUGAR).
- La metformina DEBE suspenderse siempre ante sepsis, shock, insuficiencia renal aguda, hipoxemia o uso de contraste yodado por riesgo de acidosis láctica.
- Las sulfonilureas deben suspenderse al ingresar al hospital por el riesgo extremo de hipoglicemias prolongadas en pacientes con ingesta errática.
- El uso exclusivo del esquema móvil de insulina rápida (sliding scale) está proscrito por ineficaz y riesgoso; debe usarse un esquema basal-corrección.

## ALGORITMO · HIPERGLICEMIA EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción




## TABLA 3.3 · MANEJO DE FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO

| FÁRMACO / ESQUEMA | CONDUCTA AL INGRESO | RIESGO PRINCIPAL | ESTRATEGIA DE REEMPLAZO |
|---|---|---|---|
| **Metformina** | SUSPENDER sistemáticamente | Acidosis láctica ante sepsis, hipoxemia o contraste | Insulina basal + bolos de corrección |
| **Sulfonilureas (Glibenclamida)** | SUSPENDER sistemáticamente | Hipoglicemia severa y prolongada (inapetencia / ayuno) | Insulina basal + bolos de corrección |
| **iSGLT2 (Dapagliflozina, etc.)** | SUSPENDER sistemáticamente | Cetoacidosis diabética euglicémica y deshidratación | Insulina subcutánea programada |
| **Esquema Móvil Aislado ("Sliding scale")** | PROSCRIBIR como terapia única | Ineficacia, hiperglicemia de rebote e hipoglicemia | Esquema Basal-Bolo o Basal-Corrección |
| **Insulina Cristalina EV en Bomba** | De elección en UCI y paciente crítico | Hipoglicemia si no hay control horario | Control de hemoglucotest c/1-2 horas |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| FÁRMACO O ESQUEMA | CONDUCTA | POR QUÉ |
|---|---|---|
| **Meta en todo hospitalizado** | 140–180 mg/dL | < 110 aumenta la mortalidad |
| **Prednisona matinal, ayuno normal, glicemias de 250 en la tarde** | NPH matinal junto con la prednisona | Basal nocturna guiada por el ayuno |

**REGLA DE ORO** **140 a 180 mg/dL** — Menos de 110 aumenta la mortalidad

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **44–45** (pág. 14) · solucionario pág. 27.

**Clase 3.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

# 3.4 Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.02.2.006 Hipoglicemias — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

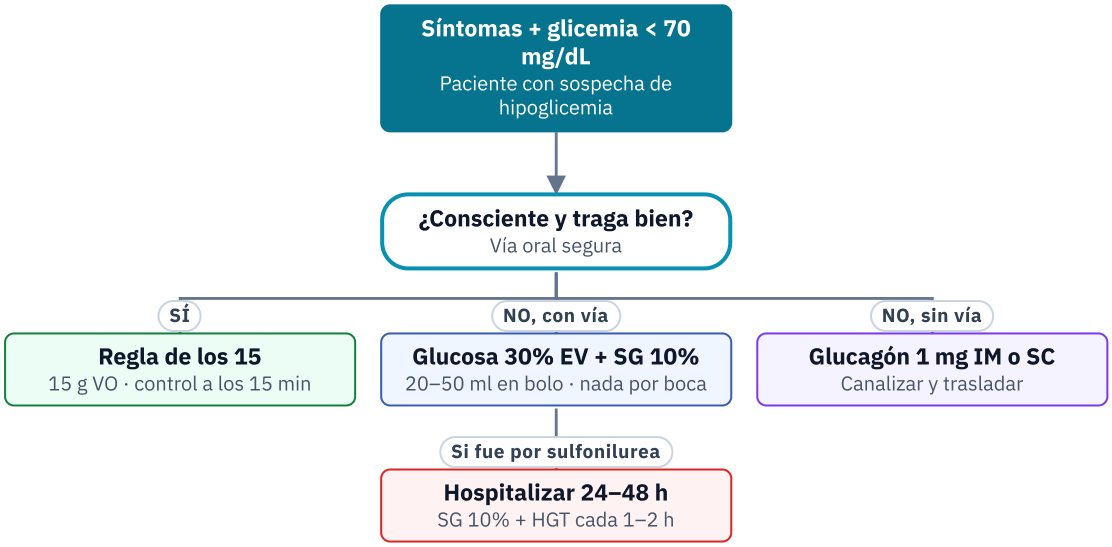
**También:** Insulinemia · Glicemia capilar · Compromiso de conciencia

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **La Tríada de Whipple exige**: síntomas de hipoglicemia + glicemia baja comprobada + alivio inmediato tras recibir glucosa.
- **La Regla de los 15 (para pacientes conscientes)**: 15 gramos de carbohidratos simples por boca, esperar **15 minutos** y repetir glicemia.
- En pacientes inconscientes está PROHIBIDO dar líquidos o alimentos orales; se indica Glucosa al **30%** EV (**20-50 ml**) o Glucagón **1 mg** IM/SC.
- ¡REGLA ABSOLUTA DE EUNACOM! Todo paciente con hipoglicemia por sulfonilureas (glibenclamida) DEBE hospitalizarse por **24 a 48 horas** con infusión de suero glucosado.
- Los betabloqueadores no cardioselectivos (propranolol) bloquean la taquicardia, palpitaciones y temblor de la hipoglicemia, pero NO la sudoración.

## ALGORITMO · HIPOGLICEMIA: RESCATE Y DESTINO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 3.4 · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE LA HIPOGLICEMIA SEGÚN ADA Y MINSAL

| NIVEL DE SEVERIDAD | VALOR BIOQUÍMICO | MANIFESTACIONES CLÍNICAS | ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PRIMARIA |
|---|---|---|---|
| **Nivel 1 (Alerta)** | Glicemia < 70 mg/dL y ≥ 54 mg/dL | Síntomas adrenérgicos leves (sudoración, temblor, hambre) | Regla de los 15 por vía oral (15 g de hidratos de carbono simples) |
| **Nivel 2 (Significativa)** | Glicemia < 54 mg/dL (< 3.0 mmol/L) | Síntomas neuroglucopénicos incipientes (confusión, cefalea) | Carbohidratos orales rápidos inmediatos + colación compleja |
| **Nivel 3 (Severa)** | Sin umbral numérico fijo | Compromiso de conciencia, convulsión, incapacidad de autotratamiento | Glucosa al 30% EV en bolo (20-50 ml) o Glucagón 1 mg IM/SC |

## TRAMPAS EUNACOM

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Consciente, traga bien** | Regla de los 15 | Glucagón o vía venosa de entrada |
| **Inconsciente, con vía venosa** | Glucosa 30% EV 20–50 ml + SG 10% | Dar jugo o azúcar por boca |
| **Inconsciente, sin vía, en domicilio** | Glucagón 1 mg IM o SC | Esperar la ambulancia sin tratar |

**REGLA DE ORO** **Síntomas + glicemia baja + alivio** — Nivel 3 se define por la clínica

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **46–54** (págs. 14–15) · solucionario págs. 27–28.

**Clase 3.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

# 4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

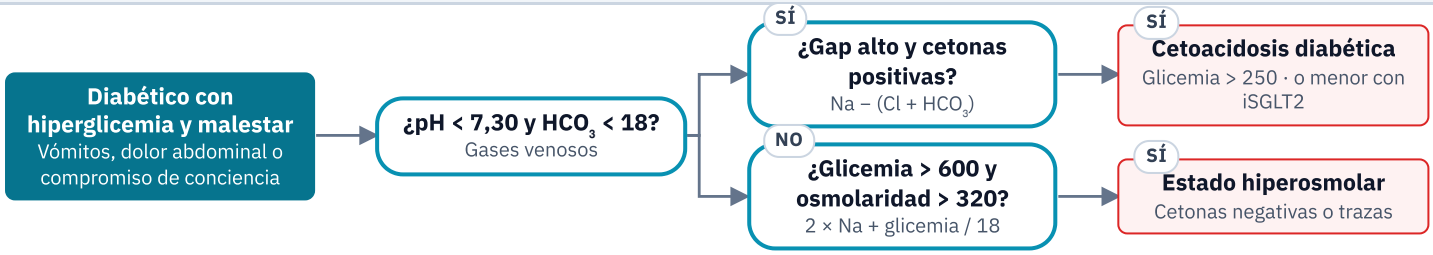
1.02.2.002 Cetoacidosis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

**También:** Síndrome hiperosmolar no cetósico · Coma hiperosmolar · Cuerpos cetónicos en sangre · Cuerpos cetónicos en orina (semicuantitativo)

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **La CAD se define por la tríada**: Glicemia > **250 mg/dL** + pH < 7.30 (o HCO3 < 18) + Anion Gap > **10–12 mEq/L** con cetonemia positiva.
- **El EHH se define por**: Glicemia > **600 mg/dL** + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > **18 mEq/L** sin cetosis.
- **La osmolaridad efectiva se calcula**: 2 * Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.
- En la CAD, el dolor abdominal y los vómitos simulan frecuentemente un abdomen agudo; ceden al corregir la acidosis con fluidos e insulina.
- La respiración de Kussmaul (taquipnea profunda y rápida) es la compensación respiratoria fisiológica para barrer CO2 ante la cetoacidosis.
- **El sodio medido debe corregirse siempre**: Na corregido = Na medido + 1.6 * ((Glicemia - 100) / 100).

## ALGORITMO · DIABÉTICO DESCOMPENSADO: CAD O EHH




## TABLA 4.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO Y CLÍNICO: CAD VS EHH

| PARÁMETRO | CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD) | ESTADO HIPERGLICÉMICO HIPEROSMOLAR (EHH) |
|---|---|---|
| **Población Típica** | DM1 niños o jóvenes (debut 25-30% o abandono insulina) | DM2 adultos mayores o ancianos institucionalizados |
| **Tiempo de Instalación** | Agudo y rápido (< 24 a 48 horas) | Insidioso y progresivo (días a semanas) |
| **Nivel de Glicemia** | 250 a 600 mg/dL (o < 250 mg/dL en euglicémica por iSGLT2) | Típicamente > 600 a 1200 mg/dL |
| **pH Arterial / Venoso** | < 7.30 (moderada < 7.24, severa < 7.00) | > 7.30 (habitualmente > 7.35) |
| **Bicarbonato Sérico** | < 18 mEq/L (severa < 10 mEq/L) | > 18 mEq/L (normal o levemente disminuido) |
| **Anion Gap** | ELEVADO (> 10 a 12 mEq/L) | Normal (< 12 mEq/L) |
| **Cetonemia / Cetonuria** | POSITIVA intensa (beta-hidroxibutirato > 3 mmol/L) | Negativa o trazas mínimas |
| **Osmolaridad Efectiva** | Variable, habitualmente < 320 mOsm/kg | MARCADAMENTE ELEVADA (> 320 mOsm/kg) |
| **Déficit de Volumen** | Moderado (3 a 6 litros, ~10% peso corporal) | Severo y extremo (8 a 12 litros, ~15-20% peso) |
| **Clínica Cardinal** | Dolor abdominal (abdomen agudo médico), vómitos, Kussmaul | Sopor, estupor, coma, signos focales neurológicos |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| PARÁMETRO | CETOACIDOSIS | ESTADO HIPEROSMOLAR |
|---|---|---|
| **Paciente e instalación** | Joven DM1 · < 24–48 h | Adulto mayor DM2 · días a semanas |
| **Seguimiento de la cetoacidosis ya en tratamiento** | Anión gap, bicarbonato y beta-hidroxibutirato | Guiarse por la tira de cetonuria |

**REGLA DE ORO** **> 250 + pH < 7,30 + gap alto** — Con cetonas positivas

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **56–64** (págs. 16–17) · solucionario págs. 29–30.

**Clase 4.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

# 4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

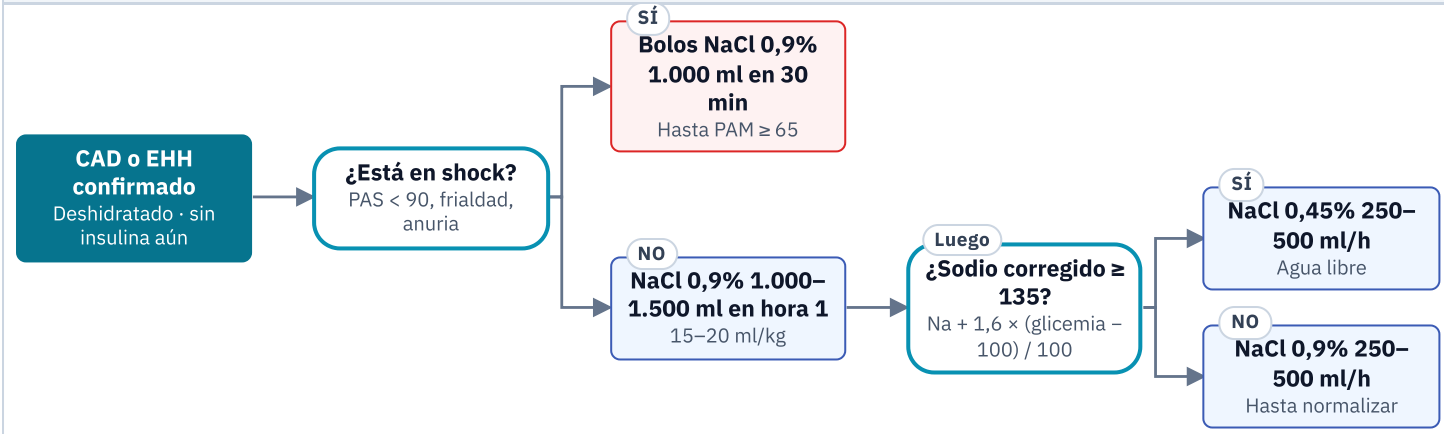
1.02.2.002 Cetoacidosis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

**También:** Síndrome hiperosmolar no cetósico · Coma hiperosmolar · Diabetes

## LO QUE TE PREGUNTAN

- La primera medida de reanimación en toda crisis hiperglicémica es SIEMPRE la fluidoterapia isotónica (NaCl **0.9% 1.000 a 1.500 ml** en la primera hora).
- Nunca debe administrarse insulina antes de iniciar la expansión de volumen, ya que precipitaría un colapso cardiovascular por arrastre osmótico de agua al intracelular.
- **Tras la primera hora, se evalúa el Sodio Corregido**: si es **≥ 135 mEq/L** se cambia a solución salina hipotónica al **0.45%**; si es < **135 mEq/L** se continúa con NaCl **0.9%**.
- **Regla mandataria**: cuando la glicemia sea **≤ 200 mg/dL** en CAD o **≤ 300 mg/dL** en EHH, se DEBE agregar Suero Glucosado al **5%** a la hidratación.
- La insulina NUNCA debe suspenderse al llegar a **200 mg/dL** si el Anion Gap sigue abierto; se reduce su dosis y se infunde glucosa parenteral.
- El déficit hídrico medio es de 3 a 6 litros en CAD y de 8 a 12 litros en EHH; su reposición debe completarse en **24 a 48 horas**.

## ALGORITMO · FLUIDOTERAPIA EN CAD Y EHH




## TABLA 4.2 · ESQUEMA CRONOLÓGICO DE FLUIDOTERAPIA EN EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS (CAD Y EHH)

| FASE DEL TRATAMIENTO | TIEMPO / PARÁMETRO CLAVE | SOLUCIÓN INTRAVENOSA | VELOCIDAD DE INFUSIÓN | OBJETIVO CLÍNICO |
|---|---|---|---|---|
| **Fase 1: Expansión Inicial** | Hora 1 (todos los pacientes) | NaCl 0.9% (Suero Fisiológico) | 1.000 a 1.500 ml/h (15-20 ml/kg) | Restaurar volemia eficaz y perfusión renal |
| **Fase 2A: Na Corregido Normal/Alto** | Horas 2 a 24 (Na corr ≥ 135) | NaCl 0.45% (Solución Hipotónica) | 250 a 500 ml/h | Reponer déficit de agua libre intracelular |
| **Fase 2B: Na Corregido Bajo** | Horas 2 a 24 (Na corr < 135) | NaCl 0.9% (Suero Fisiológico) | 250 a 500 ml/h | Corregir hiponatremia y sostener intravascular |
| **Fase 3: Transición Glucídica (CAD)** | Glicemia alcanza ≤ 200 mg/dL | Suero Glucosado 5% en NaCl 0.45% | 150 a 250 ml/h | Prevenir hipoglicemia y PERMITIR continuar insulina |
| **Fase 3: Transición Glucídica (EHH)** | Glicemia alcanza ≤ 300 mg/dL | Suero Glucosado 5% en NaCl 0.45% | 150 a 250 ml/h | Evitar caída brusca de osmolaridad y edema cerebral |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| MOMENTO | SUERO | VELOCIDAD |
|---|---|---|
| **Shock: PAS < 90** | Bolos de NaCl 0,9% | 1.000 ml en 30 min hasta PAM ≥ 65 |

**REGLA DE ORO** **Suero fisiológico antes que insulina** — 1.000–1.500 ml en la primera hora

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **65–68** (pág. 17) · solucionario págs. 30–31.

**Clase 4.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

# 4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato

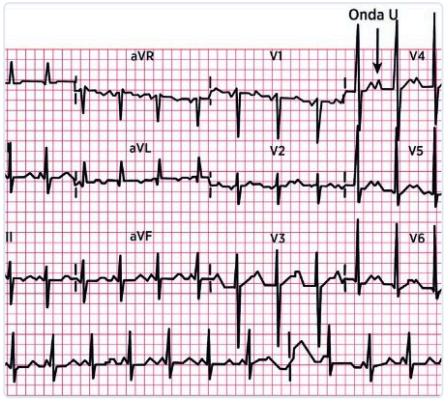
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.02.2.002 Cetoacidosis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

**También:** Hipokalemia · Síndrome hiperosmolar no cetósico · Electrocardiograma

## LO QUE TE PREGUNTAN

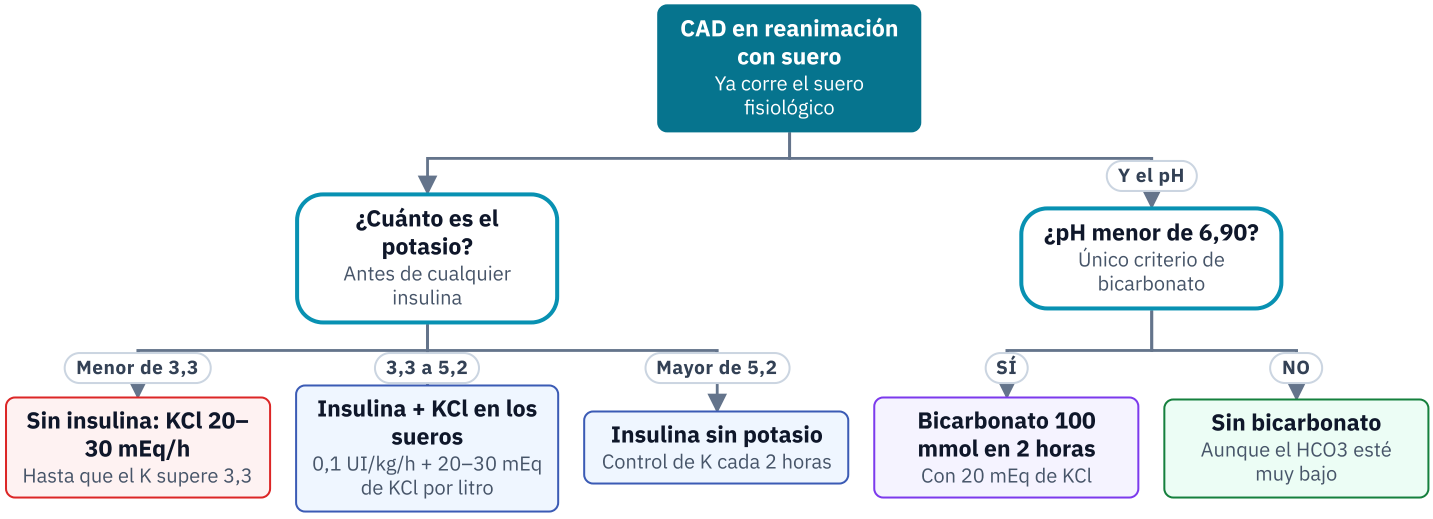
- Si la potasemia es < **3.3 mEq/L**, la insulina está FORMALMENTE CONTRAINDICADA hasta que se reponga potasio y supere dicho umbral.
- Si el potasio está entre 3.3 y **5.2 mEq/L**, se inicia insulina pero se deben agregar 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de solución de hidratación.
- El bicarbonato de sodio está estrictamente restringido a pacientes con acidosis extrema con pH < 6.90.
- Administrar bicarbonato con pH **≥ 6.90 empeora** la hipokalemia, produce acidosis paradójica del líquido cefalorraquídeo y retrasa la curación.
- La tasa de infusión de insulina cristalina de elección es de **0.1 UI**/kg/hora por vía endovenosa continua.




**ONDA U**
Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 22

## ALGORITMO · CETOACIDOSIS: POTASIO, INSULINA Y BICARBONATO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 4.3 · ALGORITMO DE MANEJO DEL POTASIO PLASMÁTICO DURANTE LA INSULINOTERAPIA EN CAD

| POTASEMIA MEDIDA (K+) | CONDUCTA CON LA INSULINA | APORTE DE CLORURO DE POTASIO (KCL) | OBJETIVO CLÍNICO |
|---|---|---|---|
| **< 3.3 mEq/L (Hipokalemia severa)** | ¡NO INICIAR o SUSPENDER de inmediato! | Infundir 20 a 30 mEq/hora de KCl hasta K > 3.3 | Prevenir paro cardíaco en diástole o arritmias fatales |
| **3.3 a 5.2 mEq/L (Rango óptimo)** | Iniciar o mantener a 0.1 UI/kg/hora | Agregar 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de hidratación | Mantener potasemia estable entre 4.0 y 5.0 mEq/L |
| **> 5.2 mEq/L (Hiperkalemia)** | Iniciar insulina a 0.1 UI/kg/hora | NO aportar potasio; controlar cada 2 horas | Permitir que la insulina baje el potasio a rango normal |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **K menor de 3,3 mEq/L** | Suspender insulina; KCl 20–30 mEq/h | Iniciar insulina y reponer K después |
| **K mayor de 5,2 mEq/L** | Insulina sin K; control cada 2 h | Tratar la hiperkalemia con calcio |
| **Glicemia no baja 50 mg/dL en la 1ª hora** | Duplicar la infusión | Esperar otra hora igual |

**REGLA DE ORO** **Siempre hay déficit total** — Aunque la potasemia sea normal o alta

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **69–70** (pág. 18) · solucionario pág. 31.

**Clase 4.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

# 4.4 Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

1.02.2.002 Cetoacidosis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

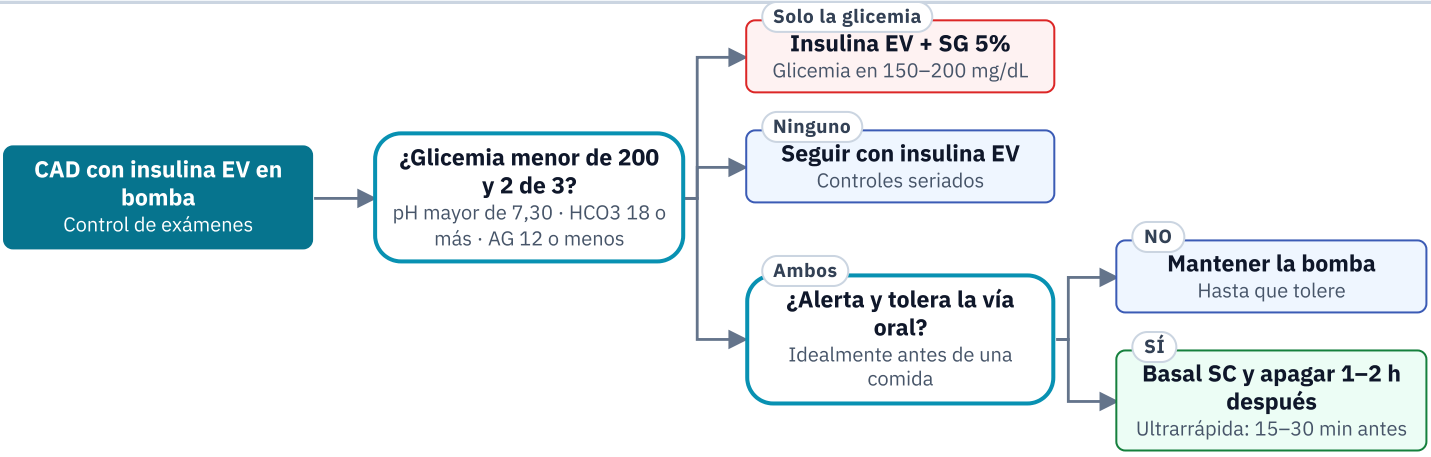
**También:** Síndrome hiperosmolar no cetósico

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **La CAD está resuelta cuando**: Glicemia < **200 mg/dL** Y al menos 2 criterios entre pH > 7.30, HCO3 **≥ 18 mEq/L** y Anion Gap **≤ 12 mEq/L**.
- El EHH está resuelto cuando la Osmolaridad plasmática efectiva es < 315 mOsm/kg y el paciente está lúcido.
- La vida media de la insulina cristalina por vía endovenosa es de solo **5 a 9 minutos**.
- La insulina basal subcutánea debe inyectarse **1 a 2 horas** ANTES de apagar la bomba de infusión continua endovenosa.
- Apagar la bomba en el momento exacto del pinchazo subcutáneo genera un periodo de carencia insulínica que reactiva la cetoacidosis en pocas horas.
- El traslape debe coincidir preferentemente con una comida principal (desayuno o almuerzo) para evaluar la tolerancia digestiva.

## ALGORITMO · CAD EN TRATAMIENTO: ¿SE PUEDE APAGAR LA BOMBA?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 4.4 · CRITERIOS DE RESOLUCIÓN Y REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL TRASLAPE

| PARÁMETRO | CRITERIO DE RESOLUCIÓN CAD | CRITERIO DE RESOLUCIÓN EHH | REGLA DE ORO EN EL TRASLAPE |
|---|---|---|---|
| **Glicemia** | < 200 mg/dL | < 250 – 300 mg/dL | Mantener en 150-200 mg/dL con SG 5% hasta resolución |
| **pH Venoso / Arterial** | pH venoso > 7.30 (arterial > 7.35) | pH > 7.30 | No suspender bomba si pH < 7.30 aunque glicemia sea normal |
| **Bicarbonato Sérico** | ≥ 18 mEq/L | > 18 mEq/L | El bicarbonato normal es el mejor marcador de recuperación |
| **Anion Gap** | ≤ 12 mEq/L (Normalizado) | Normal | Confirma que los cetoácidos circulantes han sido eliminados |
| **Osmolaridad Efectiva** | Normal (< 300 mOsm/kg) | < 315 mOsm/kg | Correlaciona con el despertar neurológico |
| **Momento de Suspensión EV** | 1 a 2 horas tras la inyección basal SC | 1 a 2 horas tras la inyección basal SC | ¡NUNCA apagar la bomba EV simultáneamente con el pinchazo SC! |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| PARÁMETRO | RESOLUCIÓN CAD | RESOLUCIÓN EHH | REGLA EN EL TRASLAPE |
|---|---|---|---|
| **pH** | Venoso mayor de 7,30 | Mayor de 7,30 | No apagar con pH menor de 7,30 |

**REGLA DE ORO** **CAD: glicemia menor de 200 + 2 de 3** — pH mayor de 7,30 · HCO3 18 o más · AG 12 o menos

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **71–72** (pág. 18) · solucionario pág. 31.

**Clase 4.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

# 4.5 Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

*Alta · Edema cerebral en pediatría/adolescentes y reposición de fosfato en debilidad muscular*

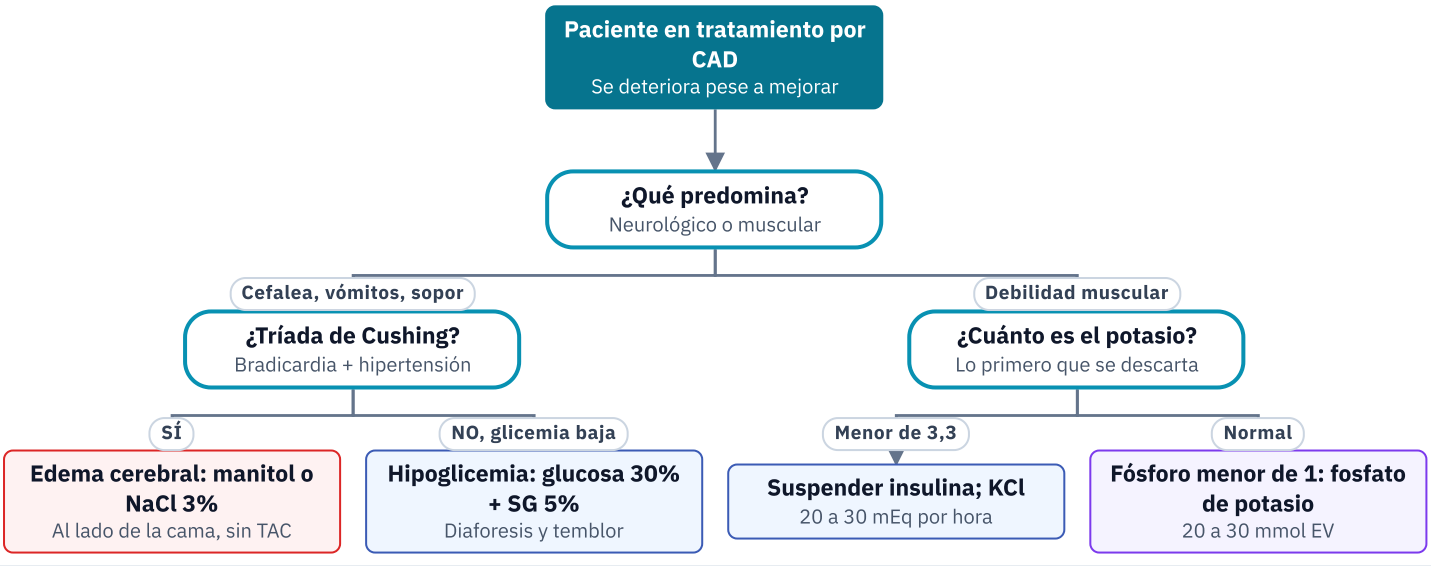
1.02.2.002 **Cetoacidosis** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

**También:** Síndrome hiperosmolar no cetósico

## LO QUE TE PREGUNTAN

- El edema cerebral es la principal causa de muerte en niños con CAD (**60–90%** de la mortalidad pediátrica).
- Ocurre típicamente a las **4–12 horas** de tratamiento, cuando la glicemia y acidosis parecen estar mejorando.
- **La Tríada de Cushing consiste en**: Bradicardia + Hipertensión arterial + Depresión respiratoria o neurológica.
- **¡REGLA VITAL!**: El tratamiento con Manitol al **20%** o Solución Salina Hipertónica al **3%** se inicia INMEDIATAMENTE ante la sospecha clínica, SIN ESPERAR TAC.
- La hipofosfemia severa (< **1.0 mg/dL**) produce debilidad de la musculatura respiratoria diafragmática e imposibilidad de destete ventilatorio.
- Para prevenir el edema cerebral, la glicemia nunca debe descender a más de **75–100 mg/dL** por hora.

## ALGORITMO · DETERIORO DURANTE EL TRATAMIENTO DE LA CAD




## TABLA 4.5 · COMPLICACIONES GRAVES DERIVADAS DEL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERGLICÉMICAS

| COMPLICACIÓN IATROGÉNICA | MECANISMO GATILLANTE | SIGNOS CLÍNICOS CLAVE | TRATAMIENTO DE EMERGENCIA |
|---|---|---|---|
| **Edema Cerebral Agudo** | Descenso osmolar brusco por exceso de fluidos hipotónicos o caída rápida de glicemia | Cefalea intensa, bradicardia, vómitos, hipertensión, sopor | Manitol 20% (0.5-1 g/kg) o NaCl 3% (5 ml/kg) inmediato al lado de la cama |
| **Hipokalemia Severa** | Administración de insulina sin chequear K+ o sin aporte de mantención | Debilidad muscular, parálisis flácida, onda U en ECG, arritmias ventriculares | Suspender insulina e infundir KCl a 20-30 mEq/h en fluidos |
| **Hipofosfemia Crítica (< 1.0 mg/dL)** | Captación intracelular forzada por la insulina y glucosuria previa | Falla ventilatoria por debilidad diafragmática, rabdomiólisis, parestesias | Fosfato de potasio 20 a 30 mmol EV en infusión lenta |
| **Hipoglicemia Severa** | No agregar suero glucosado al alcanzar 200 mg/dL manteniendo insulina | Diaforesis, temblor, convulsiones, neuroglucopenia | Glucosa al 30% EV en bolo (20-50 ml) y adición de SG 5% |

**REGLA DE ORO** **Empeora cuando los exámenes mejoran** — A las 4–12 horas, sobre todo en niños

**PRACTICA** Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Diabetes Mellitus**: usa las preguntas de la clase (QR).

**Clase 4.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

# 5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

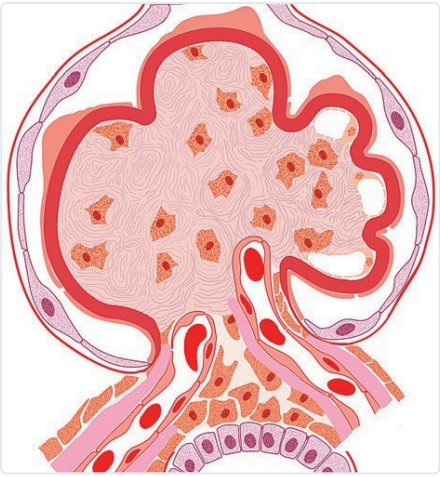
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
9 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.010 **Nefropatía incipiente** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**También:** Nefropatía diabética · Relación albuminuria / creatininuria · Insuficiencia renal y diabetes · Microalbuminuria

## LO QUE TE PREGUNTAN

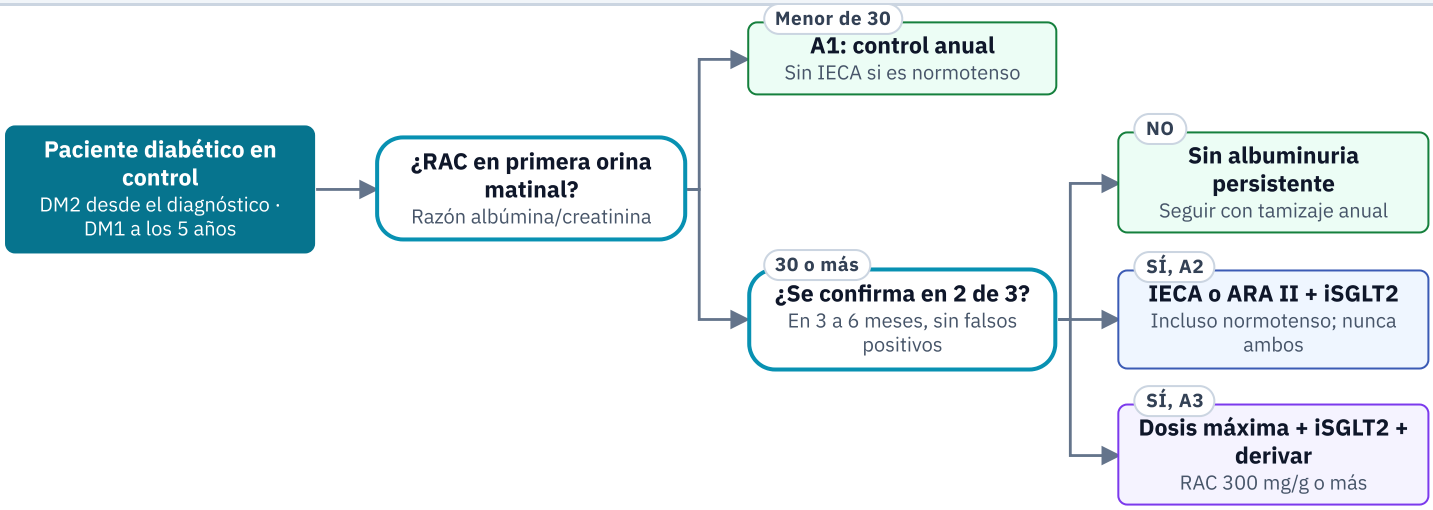
- El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la mañana.
- El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los **5 años** del debut en DM1.
- Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y **299 mg**/g en al menos 2 de 3 muestras en **3 a 6 meses**.
- La presencia de microalbuminuria persistente exige iniciar IECA o ARA II, INCLUSO SI EL PACIENTE ES TOTALMENTE NORMOTENSO.
- Los IECA/ARA II actúan dilatando preferentemente la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión capilar intraglomerular.
- Está contraindicado combinar un IECA y un ARA II en el mismo paciente por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia severa.



**GLOMERULOESCLEROSIS NODULAR**
Goljan, Rapid Review Pathology, Link 20-48

## ALGORITMO · NEFROPATÍA DIABÉTICA: DEL TAMIZAJE A LA NEFROPROTECCIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 5.1 · CATEGORÍAS DE ALBUMINURIA SEGÚN GUÍAS KDIGO Y METAS CLÍNICAS

| CATEGORÍA KDIGO | RANGO RAC (MG/G) | DENOMINACIÓN CLÁSICA | RIESGO PROGRESIÓN | CONDUCTA FARMACOLÓGICA EUNACOM |
|---|---|---|---|---|
| **A1** | < 30 mg/g | Normoalbuminuria | Bajo | Control anual; no requiere IECA si es normotenso |
| **A2** | 30 – 299 mg/g | Microalbuminuria | Moderado / Alto | INICIAR IECA o ARA II (incluso normotenso) + iSGLT2 |
| **A3** | ≥ 300 mg/g | Macroalbuminuria / Proteinuria | Muy Alto | Titular IECA/ARA2 a dosis máxima + iSGLT2 + Derivar |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| CATEGORÍA (RAC) | RIESGO DE PROGRESIÓN | CONDUCTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|---|
| **Una sola RAC alterada** | Aún no se sabe | Repetir: 2 de 3 en 3 a 6 meses | Etiquetar con una muestra |
| **DM2 recién diagnosticada** | Puede venir con daño | RAC desde el diagnóstico | Esperar 5 años como en DM1 |

**REGLA DE ORO** **DM2 desde el diagnóstico; DM1 a los 5 años** — Luego cada año

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **74–78** (págs. 18–19) · solucionario págs. 31–32.

**Clase 5.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

# 5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

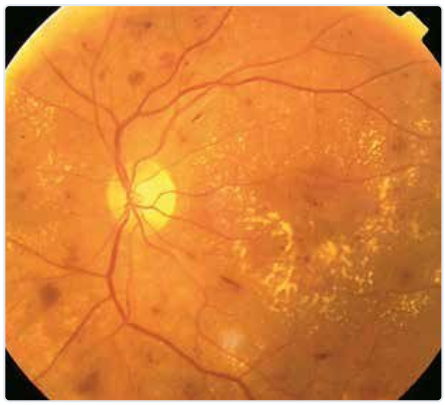
1.02.1.015
6.02.1.023
**Retinopatía diabética**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**También:** Fondo de ojo

## LO QUE TE PREGUNTAN

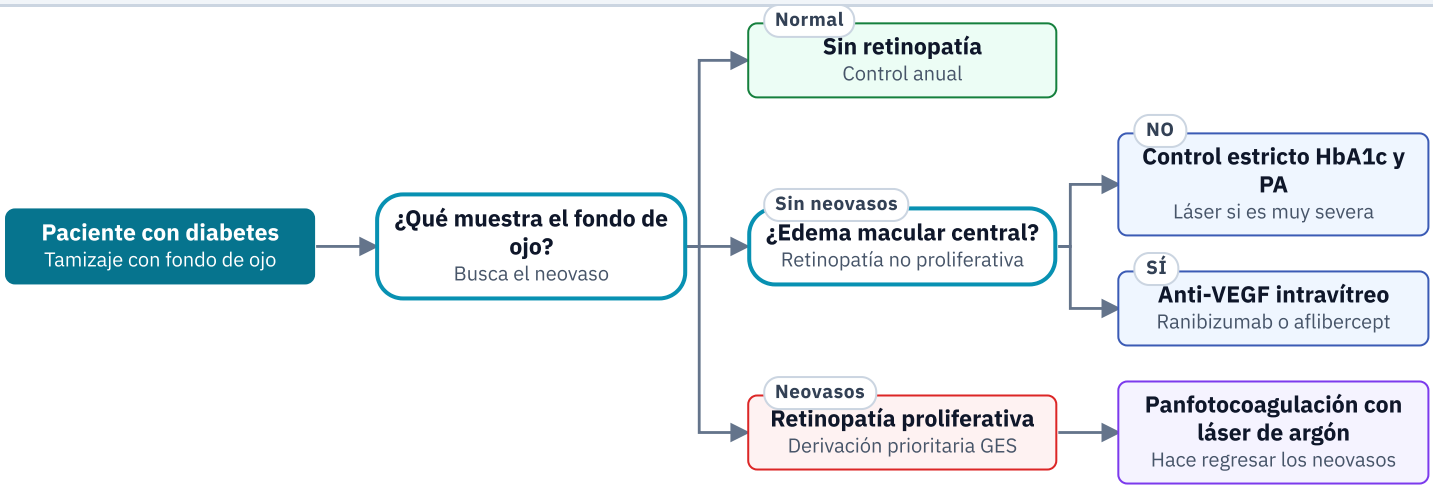
- La lesión más precoz y primera manifestación observable de la retinopatía diabética son los MICROANEURISMAS.
- La Retinopatía Proliferativa se define exclusivamente por la presencia de NEOVASOS (en la papila o retina).
- La principal causa de pérdida visual moderada en DM2 es el EDEMA MACULAR DIABÉTICO (tratado con Anti-VEGF intravítreo).
- El tratamiento estándar para la Retinopatía Proliferativa es la PANFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER DE ARGÓN (garantizada por el GES).
- La pérdida súbita e indolora de la visión con abolición del reflejo rojo en un paciente diabético orienta de inmediato a HEMORRAGIA VÍTREA.



**HEMORRAGIAS Y EXUDADOS DUROS**
Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 67

## ALGORITMO · RETINOPATÍA DIABÉTICA: DEL TAMIZAJE AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 5.2 · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA Y PROLIFERATIVA

| CARACTERÍSTICA | RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA (RDNP) | RETINOPATÍA PROLIFERATIVA (RDP) |
|---|---|---|
| **Signo Patognomónico** | Microaneurismas y exudados duros/algodonosos | NEOVASOS (retinianos o en papila óptica) |
| **Lesión más precoz** | Microaneurismas capilares (puntos rojos temporales) | Surge tras isquemia retiniana extensa y prolongada |
| **Mecanismo de daño visual** | Edema macular diabético secundario | Hemorragia vítrea, desprendimiento traccional, neovasos |
| **Tratamiento Oftalmológico** | Control glicémico/PA estricto; Anti-VEGF si edema macular | PANFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER DE ARGÓN (GES) |
| **Derivación GES** | Prioridad electiva según severidad | DERIVACIÓN URGENTE A OFTALMOLOGÍA (plazo GES 30-60 días) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| ESCENARIO | RESPUESTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **¿Qué define la proliferativa?** | Neovasos en papila o retina | Muchas hemorragias o exudados |
| **Exudado algodonoso** | Microinfarto por isquemia | Confundirlo con fuga lipídica |
| **DM2 recién diagnosticada** | Fondo de ojo de inmediato | Esperar 5 años como en DM1 |

**REGLA DE ORO** **Lesión más precoz: microaneurismas** — Por pérdida de pericitos

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **79–81** (pág. 19) · solucionario pág. 32.

**Clase 5.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

# 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

*Máxima · Tamizaje con monofilamento de 10 g, clasificación de Wagner, prueba de estilete óseo y criterios de hospitalización/amputación*

**1.02.1.014** **Pié diabético y otras infecciones en diabetes** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**También:** Neuropatía diabética · Curaciones básicas del pié diabético · Pie diabético · Insuficiencia arterial crónica · Vasculopatía periférica · Prevención de pié diabético · Arteriografia extremidades inferiores · Doppler vascular periférico

## LO QUE TE PREGUNTAN

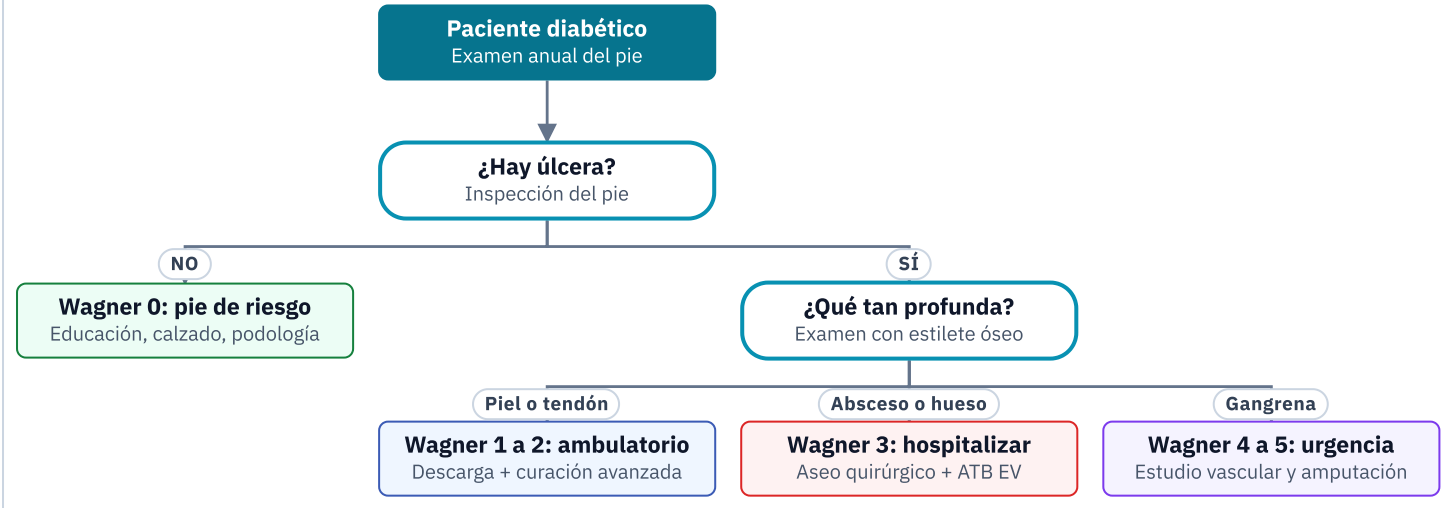
- El monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos es la herramienta de elección para evaluar la pérdida de la sensibilidad protectora en APS.
- La úlcera neuropática clásica (mal perforante plantar) es INDOLORA, se ubica en zonas de apoyo y está rodeada de un grueso borde hiperqueratósico.
- La prueba del estilete óseo positiva ("probe-to-bone") confirma osteomielitis con más del **90%** de especificidad y clasifica la lesión como Wagner 3.
- Wagner 1 es úlcera superficial dérmica; Wagner 2 llega a tendón sin absceso; Wagner 3 tiene osteomielitis o absceso; Wagner 4 tiene gangrena localizada y Wagner 5 gangrena extensa.
- Todo pie diabético con Wagner 3, 4 o 5 requiere HOSPITALIZACIÓN URGENTE para desbridamiento quirúrgico y antibióticos sistémicos.
- La medida terapéutica no quirúrgica más importante para permitir la cicatrización de una úlcera plantar es la DESCARGA DE PRESIÓN ("off-loading").
- No se deben tomar cultivos de hisopado superficial de la piel perilesional; el cultivo debe ser de tejido profundo o biopsia ósea en pabellón.



**PIE NEUROPÁTICO EN GARRA**
Open-i (NLM), CC BY

## ALGORITMO · PIE DIABÉTICO: DEL TAMIZAJE A LA HOSPITALIZACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **73, 82–85** (págs. 18–20) · solucionario págs. 31, 33.

**Clase 5.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

# 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

**TABLA 5.3 · CLASIFICACIÓN DE WAGNER PARA PIE DIABÉTICO Y ESTRATEGIA TERAPÉUTICA**

| GRADO WAGNER | DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LA LESIÓN | NIVEL DE ATENCIÓN | ESTRATEGIA TERAPÉUTICA MANDATORIA |
|---|---|---|---|
| **Grado 0** | Pie de riesgo, piel intacta, callosidades y deformidades | Ambulatorio (APS) | Educación, calzado adecuado, recorte podológico de hiperqueratosis |
| **Grado 1** | Úlcera superficial sin compromiso de tendón ni hueso | Ambulatorio (APS) | Descarga de apoyo ("off-loading") + Curación avanzada no adherente |
| **Grado 2** | Úlcera profunda que expone tendón o cápsula sin absceso | Ambulatorio / Especialidad | Descarga + Desbridamiento tisular + Curación con alginato |
| **Grado 3** | Úlcera profunda con absceso, osteomielitis o flemón | Hospitalario (Urgencia) | HOSPITALIZAR + Cirugía (drenaje/ostectomía) + ATB EV 4-6 semanas |
| **Grado 4** | Gangrena localizada en dedos o talón (isquemia focal) | Hospitalario (Pabellón) | Hospitalizar + AngioTAC/Revascularización + Amputación menor |
| **Grado 5** | Gangrena extensa de todo el pie con compromiso sistémico | Hospitalario (Pabellón) | Hospitalización de urgencia vital + Amputación mayor (bajo/sobre rodilla) |

**TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA**

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Tamizaje anual de neuropatía** | Monofilamento de 10 g | Electromiografía anual |
| **Pie de riesgo sin úlcera (Wagner 0)** | Educación, calzado, podología | Derivar a urgencia |
| **Estilete toca hueso** | Wagner 3: hospitalizar | Curación ambulatoria |

**REGLA DE ORO** **Monofilamento de 10 g** — Un punto no percibido: pie de alto riesgo

**¿POR QUÉ SE PREGUNTA?**

El pie diabético es una de las complicaciones más costosas y discapacitantes de la medicina. En el EUNACOM se evalúa de manera prioritaria el tamizaje de la neuropatía sensitiva con el monofilamento de Semmes-Weinstein (10 gramos), la correcta estadificación según la Clasificación de Wagner (del grado 0 al 5), la técnica semiológica del estilete óseo ("probe-to-bone test") para el diagnóstico de osteomielitis subyacente, y las indicaciones categóricas de hospitalización, desbridamiento quirúrgico y antibióticos sistémicos.

**TABLA 5.3.B · ESQUEMA ANTIMICROBIANO ESCALONADO EN INFECCIONES DE PIE DIABÉTICO**

| SEVERIDAD DE LA INFECCIÓN | MICROORGANISMOS SOSPECHADOS | ESQUEMA ANTIBIÓTICO RECOMENDADO | VÍA Y DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Leve (Celulitis < 2 cm, superficial)** | Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. | Cefadroxilo 500 mg c/12h o Cloxacilina 500 mg c/6h VO | Vía oral por 7 a 14 días |
| **Moderada (Celulitis > 2 cm, absceso local)** | Polimicrobiana: Gram (+), Gram (-) y anaerobios | Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg c/12h VO o Ciprofloxacino + Clindamicina | Vía oral por 14 a 21 días |
| **Severa (Compromiso sistémico / Wagner 3-5)** | Polimicrobiana grave con Pseudomonas y bacteriemia | Ceftriaxona 1-2 g/d EV + Metronidazol 500 mg c/8h EV (o Piperacilina/Tazobactam) | Vía endovenosa hospitalizada |
| **Osteomielitis Comprobada (Wagner 3)** | Staphylococcus aureus y bacilos Gram negativos | Según cultivo de biopsia ósea; Ciprofloxacino + Clindamicina o Cefazolina | Vía parenteral inicial, duración total 4 a 6 semanas |

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **73, 82–85** (págs. 18–20) · solucionario págs. 31, 33.

**Clase 5.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

# 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

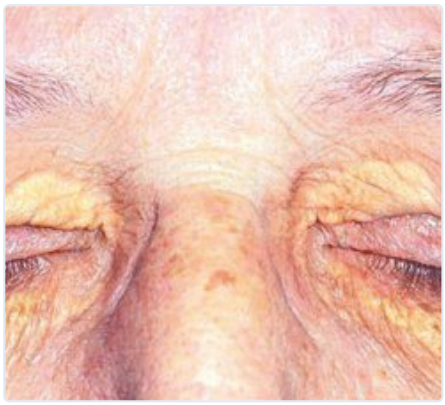
1.02.1.007
1.01.1.005
Dislipidemias

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**También:** Riesgo cardiovascular global · Perfil lipídico · Dislipidemias · Prevención de dislipidemias · Control de factores de riesgo de enfermedad vascular

## LO QUE TE PREGUNTAN

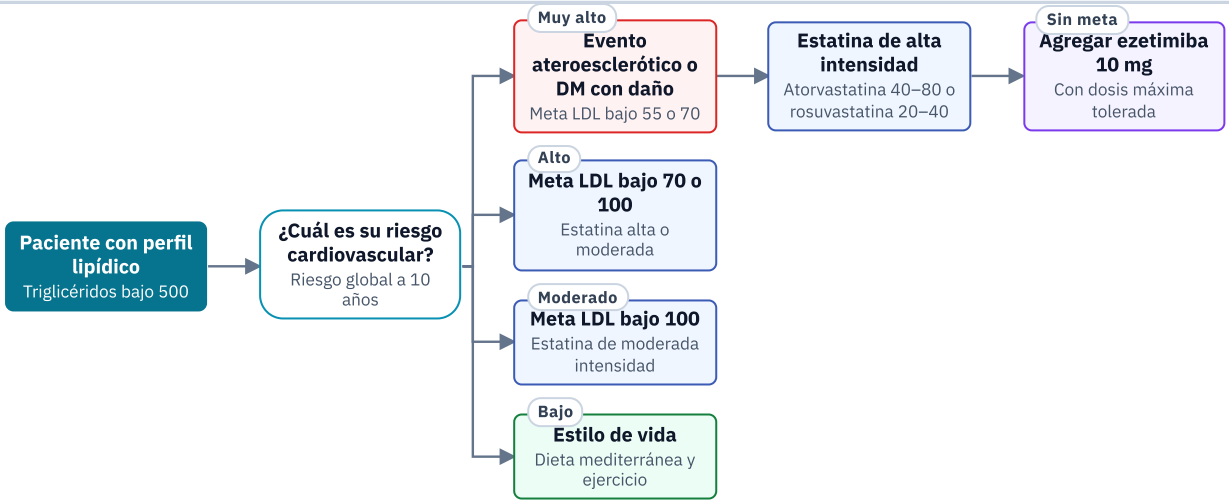
- Todo paciente con enfermedad cardiovascular clínica demostrada (IAM, ACV, arteriopatía periférica) tiene Riesgo Cardiovascular Muy Alto.
- La meta de c-LDL en Riesgo Muy Alto es < **70 mg/dL** (o < **55 mg/dL**); en Riesgo Alto es < **100 mg/dL** (o < **70 mg/dL**).
- Las estatinas de alta intensidad son Atorvastatina **40–80 mg**/día y Rosuvastatina **20–40 mg**/día (reducen el LDL en **≥ 50%**).
- El efecto adverso más frecuente son las mialgias; ante su sospecha, se debe solicitar Creatina Kinasa (CK).
- La rabdomiólisis cursa con CK > **10 veces** el límite superior normal, mioglobinuria y falla renal aguda.



**XANTELASMA**
Manual AMIR Endocrinología, p. 120

## ALGORITMO · DISLIPIDEMIA: DEL RIESGO A LA ESTATINA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción




## TABLA 5.4 · CLASIFICACIÓN DE LA POTENCIA DE LAS ESTATINAS Y METAS DE C-LDL SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR

| CATEGORÍA DE RIESGO | DEFINICIÓN CLÍNICA EUNACOM | META DE COLESTEROL LDL | RÉGIMEN DE ESTATINAS INDICADO |
|---|---|---|---|
| **Riesgo Muy Alto** | Antecedente de IAM, ACV, claudicación intermitente, DM2 con proteinuria | < 55 mg/dL (o < 70 mg/dL) | Alta intensidad: Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg |
| **Riesgo Alto** | DM2 sin daño de órgano blanco > 10a, ERC etapa 3a, Framingham ≥ 10% | < 70 mg/dL (o < 100 mg/dL) | Alta o moderada intensidad: Atorvastatina 20-40 mg |
| **Riesgo Moderado** | DM2 joven < 10a sin daño, pacientes con Framingham 5-9% | < 100 mg/dL | Moderada intensidad: Atorvastatina 10-20 mg o Simvastatina 20-40 mg |
| **Riesgo Bajo** | Score de Framingham < 5% sin comorbilidades mayores | < 116 mg/dL (o < 130 mg/dL) | Cambios terapéuticos del estilo de vida (dieta mediterránea y ejercicio) |

## TRAMPAS EUNACOM

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **IAM previo, LDL 118 con atorvastatina 10 mg** | Subir a atorvastatina 40–80 mg | Mantener porque el colesterol total es menor de 200 |
| **Prevención secundaria** | Estatina de alta intensidad | Rosuvastatina 10 o simvastatina: moderadas |
| **Ateroesclerosis documentada con LDL cercano a 90** | Iniciar estatina | No tratar porque el LDL está bajo 100 |

**REGLA DE ORO** **Evento previo = riesgo muy alto** — IAM, ACV, AIT, arteriopatía periférica

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **86–87** (pág. 20) · solucionario pág. 33.

**Clase 5.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

# 5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

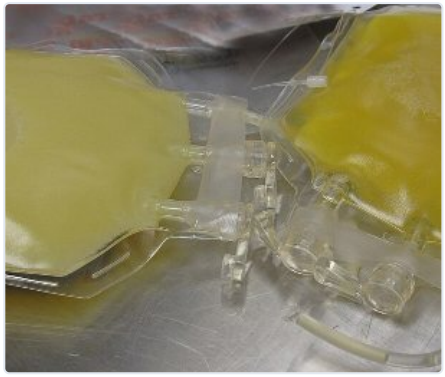
★☆☆
PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.02.2.005 **Hipertrigliceridemia grave** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**También:** Dislipidemias · Regímenes dietéticos para dislipidemias

## LO QUE TE PREGUNTAN

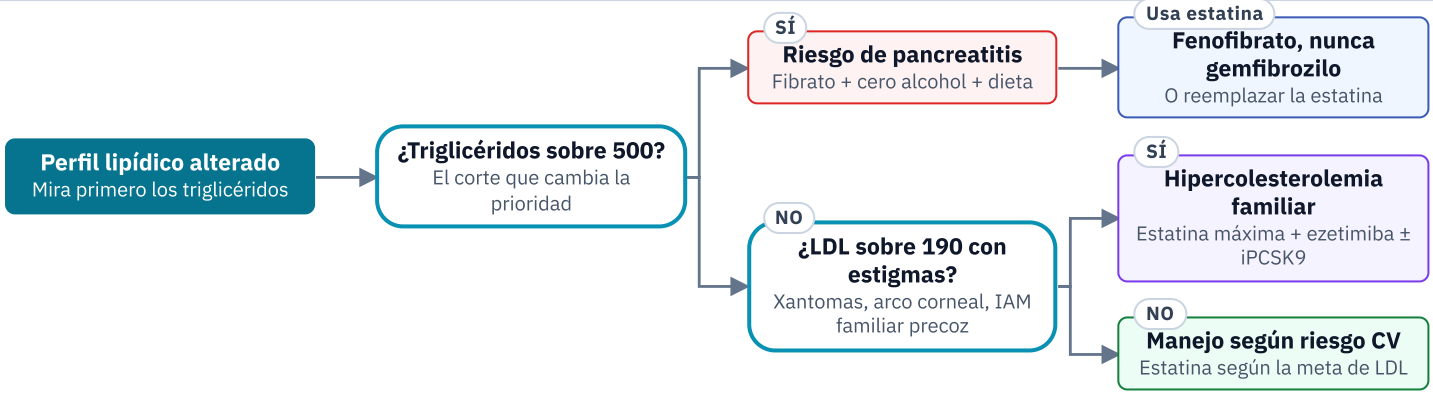
- Niveles de triglicéridos > **500 a 1.000 mg/dL** confieren un riesgo crítico de PANCREATITIS AGUDA.
- Ante triglicéridos > **500-1000 mg/dL**, el fármaco de primera línea de inicio inmediato son los FIBRATOS (Fenofibrato o Gemfibrozilo).
- El alcohol y los azúcares simples son los factores dietéticos que más incrementan la síntesis hepática de triglicéridos; deben prohibirse.
- La asociación de Gemfibrozilo con Estatinas está CONTRAINDICADA por elevado riesgo de rabdomiólisis fatal; si se requiere combinar, se usa Fenofibrato.
- La presencia de LDL > **190 mg/dL**, xantomas en tendón de Aquiles e infartos precoces en familiares es diagnóstica de Hipercolesterolemia Familiar.



**PLASMA LECHOSO**
Wikimedia Commons «Lipemic plasma.jpg», CC BY-SA 3.0, DiverDave

## ALGORITMO · DISLIPIDEMIA SEVERA: QUÉ TRATAR PRIMERO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 5.5 · CLASIFICACIÓN DE HIPERTRIGLICERIDEMIA Y RIESGO DE PANCREATITIS

| NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS | CATEGORÍA CLÍNICA | RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL | TRATAMIENTO DE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| **150 – 199 mg/dL** | Límite Alto | Riesgo cardiovascular moderado | Estilo de vida, dieta baja en azúcares simples |
| **200 – 499 mg/dL** | Moderadamente Alto | Ateroesclerosis acelerada | Estatinas si riesgo RCV alto + estilo de vida |
| **500 – 999 mg/dL** | Severo | Riesgo inminente de Pancreatitis Aguda | FIBRATO (Fenofibrato 160 mg o Gemfibrozilo) urgente |
| **≥ 1.000 mg/dL** | Crítico / Muy Severo | ALTO RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA Y QUILOMICRONEMIA | FIBRATO inmediato + Cero alcohol + Dieta cero grasa (< 15%) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **TG bajo 500 con LDL alto** | Estatina | Fibrato |
| **TG severos en usuario de estatina** | Cambiar a gemfibrozilo, o usar fenofibrato si hay que combinar | Agregar gemfibrozilo a la estatina |
| **LDL sobre 190, xantomas de Aquiles, padre con IAM joven** | Hipercolesterolemia familiar | Hiperlipidemia combinada o disbetalipoproteinemia |

**REGLA DE ORO** **TG sobre 500–1.000** — Prioridad: evitar la pancreatitis

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **88–90** (pág. 20) · solucionario pág. 34.

**Clase 5.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

# 5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

*Alta · obesidad con resistencia a la insulina que solo requiere estilo de vida, acantosis nigricans como marcador, prevención de DM2 en prediabetes y realimentación gradual en anorexia nerviosa*

1.02.1.012 **Obesidad** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**También:** Obesidad mórbida · Síndrome metabólico · Trastornos de conducta alimentaria · Alimentación saludable · Anorexia nerviosa · Prevención de Diabetes Mellitus tipo 2 · Regímenes dietéticos para obesidad · Evaluación nutricional · Nitrogeno urinario · Obesidad y sobrepeso

## LO QUE TE PREGUNTAN

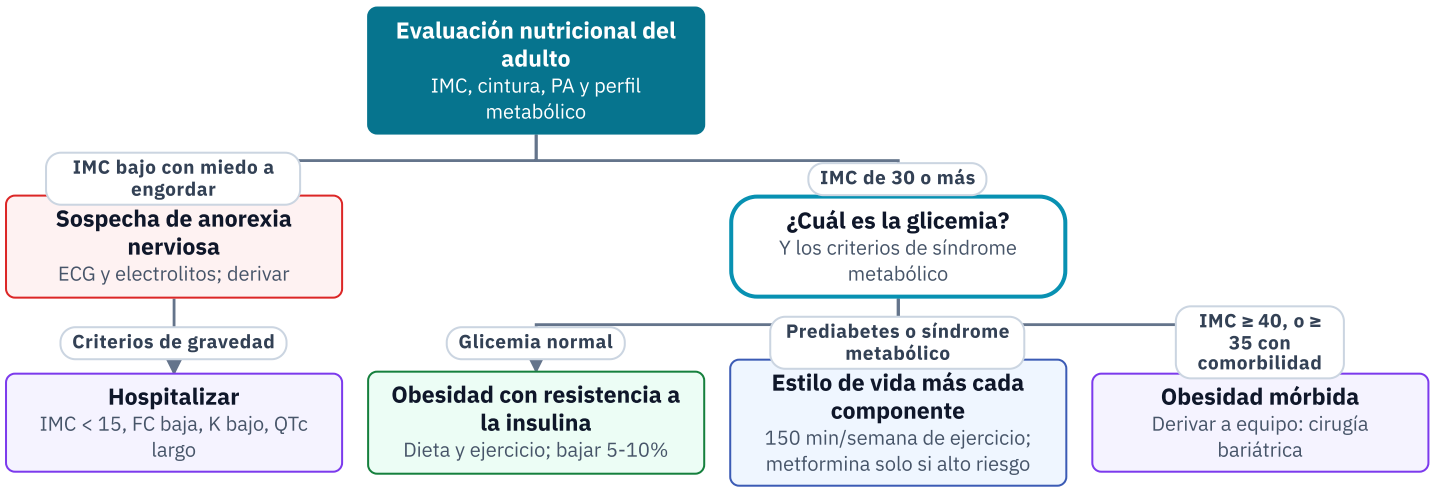
- **IMC = peso / talla²**: bajo peso < 18.5, sobrepeso 25–29.9, obesidad **≥ 30 y** obesidad mórbida **≥ 40** (o **≥ 35 con** comorbilidad); la cintura **≥ 102 cm** en hombres o **≥ 88 cm** en mujeres define obesidad abdominal.
- **Balance nitrogenado** = proteínas ingeridas / 6.25 – (NUU de **24 horas** + **4 g**); un NUU > **10 g**/día indica estrés metabólico severo y un balance negativo exige aumentar el aporte proteico-calórico.
- El obeso con glicemia normal y resistencia a la insulina solo requiere dieta y ejercicio; no se indica metformina ni insulina. La meta es bajar **5–10%** del peso en **6 meses**.
- El síndrome metabólico requiere 3 de 5 criterios (cintura, TG **≥ 150, HDL** bajo, PA **≥ 130/**85 y glicemia **≥ 100**); la acantosis nigricans es marcador de resistencia a la insulina y el tratamiento es el de cada componente más estilo de vida.
- Para prevenir la DM2 en prediabetes la intervención más importante es el estilo de vida (baja de peso y **150 minutos** semanales de ejercicio; reduce **58%** la progresión); la metformina es de segunda línea.
- **Anorexia nerviosa**: realimentar con 10–15 kcal/kg/día y tiamina, vigilando fósforo, potasio y magnesio, para prevenir el síndrome de realimentación; hospitalizar según IMC, FC, PA y electrolitos y derivar a equipo especializado.



**MANGA GÁSTRICA**
Harrison 21.ª ed., Fig. 402-3 (esquema)

## ALGORITMO · EVALUACIÓN NUTRICIONAL: OBESIDAD, SÍNDROME METABÓLICO Y TCA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción




**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **1–5, 55** (págs. 8–9, 16) · solucionario págs. 21, 29.

**Clase 5.6 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

# 5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

**TABLA 5.6 · CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO SEGÚN IMC Y CONDUCTA INICIAL**

| IMC (KG/M²) | CATEGORÍA | RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL | CONDUCTA INICIAL |
|---|---|---|---|
| **< 18.5** | Bajo peso | Desnutrición, TCA, enfermedad consuntiva | Estudiar causa; si hay miedo a engordar sospechar anorexia nerviosa y derivar |
| **18.5 – 24.9** | Normal | Riesgo habitual | Mantener alimentación saludable y ejercicio |
| **25 – 29.9** | Sobrepeso | Riesgo cardiometabólico aumentado | Estilo de vida; tamizar glicemia y perfil lipídico |
| **30 – 34.9 / 35 – 39.9** | Obesidad grado I / II | DM2, HTA, dislipidemia, apnea del sueño | Déficit calórico y ejercicio; fármacos si hay fracaso; tratar comorbilidades |
| **≥ 40 (o ≥ 35 con comorbilidad)** | Obesidad mórbida | Mortalidad cardiovascular y metabólica elevada | Derivar a equipo para evaluar cirugía bariátrica |

**TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA**

| IMC | RIESGO PRINCIPAL | CONDUCTA INICIAL |
|---|---|---|
| **Prediabetes en riesgo de DM2** | Progresión a diabetes | Ejercicio 150 min/semana y bajar peso |
| **Acantosis nigricans** | Resistencia a la insulina | Buscar prediabetes, dislipidemia e HTA |

**REGLA DE ORO** **IMC por tramos, cintura aparte** — Mórbida: ≥ 40, o ≥ 35 con comorbilidad

## ¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La nutrición clínica reúne tres escenarios de alto rendimiento. El primero es la evaluación nutricional: IMC, circunferencia de cintura, laboratorio (albúmina, prealbúmina) y el balance nitrogenado con nitrógeno ureico urinario de 24 horas para medir el catabolismo. El segundo es el exceso de peso: la obesidad con resistencia a la insulina se maneja con estilo de vida y déficit calórico, el síndrome metabólico se diagnostica con 3 de 5 criterios y se trata en sus componentes, la prediabetes se previene con 150 minutos de ejercicio y baja de peso, y la obesidad mórbida se deriva a cirugía bariátrica. El tercero es el déficit: la anorexia nerviosa exige una realimentación gradual (10 a 15 kcal/kg/día) para evitar el síndrome de realimentación.

## ASÍ SE VE · FOTOS DE LA CLASE



**ACANTOSIS NIGRICANS**
High-Yield review, p. 774

**PRACTICA** **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **1–5, 55** (págs. 8–9, 16) · solucionario págs. 21, 29.

**Clase 5.6 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

# Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 25 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

| DATO | TIPO |
|---|---|
| **BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES** | |
| **1.1 Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY** | pág. 3 |
| Adulto con sobrepeso u obesidad — Habitualmente sobre **35 a 45 años** | CORTE |
| **1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS** | pág. 4 |
| PTGO: **2 horas ≥ 200 mg/dL** — Carga de **75 g** de glucosa | DOSIS |
| HbA1c **≥ 6,5 %** — Laboratorio estandarizado | CORTE |
| HOMA-IR > 2,6 — Glicemia × insulina de ayuno / 405 | CORTE |
| **1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)** | pág. 5 |
| Ayuno **70 a 95 mg/dL** — **1 h** postprandial < 140 · **2 h** < 120 | DOSIS |
| PTGO **75g** a las **2 horas · ≥ 140 mg/dL · ≥ 200 mg/dL** | DOSIS |
| Nutrición, luego insulina — Ayuno 70–95 · **1 h** < 140 | CORTE |
| **1.4 Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas** | pág. 6 |
| Activo < **7,5 %** · frágil < **8–8,5 %** — En meta: no intensificar | META |
| HbA1c < **7 %** — Expectativa de vida sobre **15 años** | CORTE |
| Presión arterial < 130/**80 mmHg** — Si es bien tolerada | CORTE |
| **1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular** | pág. 7 |
| **150 minutos** semanales — **≥ 3 días**, fuerza **2 a 3 veces** | CORTE |
| **150 minutos** a la semana — Intensidad moderada | TIEMPO |
| **BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS** | |
| **2.1 Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL** | pág. 8 |
| Falla de biterapia máxima — NPH nocturna **0,2 UI**/kg | DOSIS |
| 500 u **850 mg** una vez al día — Con la comida principal | DOSIS |
| Subir cada **1 a 2 semanas** — Hasta **1.700 a 2.550 mg**/día | DOSIS |
| **2.2 Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas** | pág. 9 |
| VFG 30 a 44: máx. **1.000 mg** — VFG < 30: suspender (acidosis láctica) | DOSIS |
| Falla renal — VFG 30 a 44: precaución · VFG < 30: contraindicada | CORTE |
| Neutra o baja **1 a 2 kg** — Ideal en el obeso | CORTE |
| **2.3 Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4** | pág. 10 |
| Cetoacidosis euglicémica — Glicemia < **200 a 250 mg/dL** | DOSIS |
| Potencia moderada — HbA1c **–0,5 a 0,7 %** | CORTE |
| IAM o ACV previo, obesidad — Baja de peso **5 a 15 %** | CORTE |
| **2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante** | pág. 11 |
| Más del **20 %** fuera de meta — O CA fetal ≥ p75–90 | META |
| A las 3 AM: > **60 mg/dL** — Descartar hipoglicemia nocturna | DOSIS |
| **1 h** postprandial: < **140 mg/dL** — O **2 h** postprandial: < 120 | DOSIS |
| **2.5 Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal** | pág. 12 |
| PA < 130/**80 mmHg** — Biterapia si parte **≥ 140**/90 | CORTE |
| IECA o ARA-II + amlodipino — Amlodipino **5 a 10 mg**/día | DOSIS |
| **BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO** | |
| **3.1 Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio** | pág. 13 |
| NPH bedtime + metformina — **10 UI** o **0,1–0,2 UI**/kg | DOSIS |

# Números que tienes que saber · continuación

| DATO | TIPO |
|---|---|
| **5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria** (cont.) | pág. 28 |
| NPH: peak **4–10 h** — Siempre al acostarse | TIEMPO |
| Catabolismo o HbA1c **≥ 9–10 %** — Aunque sea obeso o recién diagnosticado | CORTE |
| **3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis** | pág. 14 |
| +**2 UI** si 131–180 · +**4 UI** si > 180 — Hipoglicemia: bajar **10–20 %** | DOSIS |
| 3 AM < 70: Somogyi → BAJAR — 3 AM > 100: alba → SUBIR | CORTE |
| Consultar si < 70 o dos valores > 250 — Lectura discordante: repetir | CORTE |
| **3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado** | pág. 15 |
| < **110 mg/dL**: más muertes — Evidencia del ensayo NICE-SUGAR | DOSIS |
| **140 a 180 mg/dL** — En UCI y en sala | DOSIS |
| **0,2 a 0,4 UI**/kg/día — Insulina subcutánea total | DOSIS |
| **3.4 Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate** | pág. 16 |
| Glicemia < **70 mg/dL** — Valor de alerta | DOSIS |
| Glicemia < **54 mg/dL** — Empiezan los síntomas neuroglucopénicos | DOSIS |
| **BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS** | |
| **4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)** | pág. 17 |
| Glicemia > **600 mg/dL** — Frecuente 800 a 1.200 | DOSIS |
| Glicemia > **250 mg/dL** — Típicamente entre 300 y 600 | DOSIS |
| **4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH** | pág. 18 |
| Bolos de **1.000 ml** en **30 min** — Hasta PAM **≥ 65 mmHg** | DOSIS |
| Diuresis horaria — > **0,5 ml/kg**/h · catéter vesical | DOSIS |
| **4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato** | pág. 19 |
| **0,1 UI**/kg/h — Con o sin bolo de **0,1 UI**/kg | DOSIS |
| K < 3,3 o U con arritmia — Potasio antes de la insulina | CORTE |
| **4.4 Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea** | pág. 20 |
| Glicemia menor de **200 mg/dL** — Necesaria, pero no basta | DOSIS |
| Bicarbonato **18 mEq/L** o más — El mejor marcador de recuperación | CORTE |
| **4.5 Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia** | pág. 21 |
| Menor de **5 años** o debut de DM1 — El grupo más expuesto | CORTE |
| Fósforo menor de **1,0 mg/dL** — Falla ventilatoria: fosfato de potasio EV | DOSIS |
| **BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS** | |
| **5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector** | pág. 22 |
| A2: RAC de **30 a 299 mg**/g — 2 de 3 muestras en **3 a 6 meses** | DOSIS |
| DM2: desde el diagnóstico — Y luego cada **12 meses** | TIEMPO |
| **5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES** | pág. 23 |
| Mi ojo derecho con su ojo derecho — A **2 cm** y 15° lateral | CORTE |
| Control: anual, o cada **6 meses** — Embarazo: antes y cada trimestre | TIEMPO |
| **5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico** | pág. 24 |
| Normal 0,9 a 1,3 — < 0,9 EAP · < 0,4–0,5 isquemia severa | CORTE |
| Pulsos ausentes, piel fría y atrófica — Relleno capilar > 3 segundos | CORTE |
| **5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas** | pág. 26 |
| ERC avanzada — VFG menor de **45 ml**/min | DOSIS |
| **150 min**/semana, dieta mediterránea — Sal < **5 g**/día, alcohol limitado | DOSIS |

# Números que tienes que saber · continuación

| DATO | TIPO |
|---|---|
| **5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria** (cont.) | pág. 28 |
| Ezetimiba **10 mg**/día — Baja un **15 a 20 %** adicional | DOSIS |
| **5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis** | pág. 27 |
| Colesterol < **200–300 mg**/día — Limitar yema de huevo y vísceras | DOSIS |
| Grasas saturadas < **7–10 %** de las calorías — Trans cerca de cero | CORTE |
| **5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria** | pág. 28 |
| HDL < 40 (H) o < **50 mg/dL** (M) — PA **≥ 130/**85 o tratamiento | DOSIS |
| La meta es bajar **5–10%** del peso en **6 meses**. | META |

# Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

| SITUACIÓN | FÁRMACO / ESQUEMA | DETALLE |
|---|---|---|
| **1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)** | | pág. 5 |
| Pilares · Si no logra metas en 1–2 semanas | **O hay macrosomía: insulina NPH y cristalina** | |
| **2.1 Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL** | | pág. 8 |
| Enfermedad aterosclerótica · Agonista GLP-1 | **Liraglutida o semaglutida; o un iSGLT2** | |
| Garantía GES de diabetes tipo 2 · Canasta | **Metformina y glibenclamida** | Los orales de la canasta |
| Garantía GES de diabetes tipo 2 · Canasta | **Insulina NPH y cristalina** | Jeringas, lancetas y glucómetro |
| **2.3 Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4** | | pág. 10 |
| Vía de administración | **Liraglutida** | Subcutánea diaria |
| Vía de administración | **Semaglutida** | Subcutánea semanal u oral diaria |
| **2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante** | | pág. 11 |
| Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante | **La insulina NPH y cristalina son los fármacos de elección indiscutidos; no cruzan la barrera placentaria.** | |
| **2.5 Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal** | | pág. 12 |
| La combinación prohibida · Riñón avanzado | **Segundo fármaco: furosemida o amlodipino** | |
| Biterapia de inicio | **O IECA o ARA-II + tiazida** | Hidroclorotiazida o indapamida |
| **3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis** | | pág. 14 |
| Cálculo fino y educación · En DM1 intensificada | **Ratio insulina:carbohidratos** | Regla del 500: 500 / dosis total diaria |
| **3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado** | | pág. 15 |
| Dosis del esquema basal-bolo · Dosis total diaria | **Insulina subcutánea total** | |
| **4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato** | | pág. 19 |
| La pauta de la bomba · Qué y cómo | **Insulina cristalina en infusión continua** | CAD moderada a severa y EHH |
| **5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES** | | pág. 23 |
| Tratamientos GES · Anti-VEGF intravítreo | **Ranibizumab, aflibercept: edema macular central** | |
| **5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico** | | pág. 24 |
| Esquema escalonado según la gravedad · Leve | **Cefadroxilo o cloxacilina VO** | **7 a 14 días** |
| Esquema escalonado según la gravedad · Moderada | **Amoxicilina-clavulánico o ciprofloxacino + clindamicina** | **14 a 21 días** |
| **5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas** | | pág. 26 |
| Alta vs moderada intensidad · Alta intensidad | **Atorvastatina 40 a 80 mg** | O rosuvastatina **20 a 40 mg** |
| **5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis** | | pág. 27 |
| Intensivo y de por vida | **Estatina de alta potencia a dosis máxima** | + ezetimiba + inhibidor de PCSK9 |
| **5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria** | | pág. 28 |
| Fármacos y cirugía bariátrica · Farmacoterapia | **Inhibe lipasas · esteatorrea y déficit de vitaminas** | |

## Fármacos de primera línea · continuación

| SITUACIÓN | FÁRMACO / ESQUEMA | DETALLE |
|---|---|---|
| **5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria** (cont.) | | pág. 28 |
| Fármacos y cirugía bariátrica · Farmacoterapia | **Liraglutida 3 mg, semaglutida 2,4 mg** | |

# GES de Diabetes Mellitus & Dislipidemias

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 1 y Tipo 2**

Tema **1.1** · Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY
1.02.1.004 · 1.02.1.005
pág. **3**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2 en Personas de 15 años y más**

Tema **1.2** · Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS
1.02.1.005 · 1.02.4.024 · 1.02.4.017
pág. **4**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Salud del Embarazo y Parto**

Tema **1.3** · Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)
1.02.1.002 · 1.02.1.003 · 3.01.1.004
pág. **5**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **1.4** · Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas
1.02.1.005 · 1.02.4.017 · 1.02.3.005
pág. **6**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **1.5** · Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular
1.02.3.004 · 1.02.3.003 · 1.02.2.006
pág. **7**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **2.1** · Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL
1.02.1.005 · 1.02.4.017
pág. **8**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **2.2** · Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas
1.02.1.005 · 1.02.2.006 · 1.02.2.001
pág. **9**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Salud del Embarazo y Parto**

Tema **2.4** · Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante
1.02.1.002 · 1.02.1.003 · 3.01.1.004
pág. **11**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Hipertensión Arterial Primaria y DM2**

Tema **2.5** · Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal
1.02.1.008 · 1.02.1.010
pág. **12**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y Tipo 1**

Tema **3.1** · Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio
1.02.1.005 · 1.02.1.004
pág. **13**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y Tipo 1**

Tema **3.2** · Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis
1.02.1.005 · 1.02.1.004 · 1.02.2.006
pág. **14**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **3.3** · Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado
1.02.1.005 · 1.02.4.015 · 1.02.1.006
pág. **15**

# Fármacos de primera línea · continuación

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Médica APS**

Tema **3.4** · Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate
`1.02.2.006` · `1.02.4.018` · `1.02.4.015`
pág. **16**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Hospitalaria**

Tema **4.1** · Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)
`1.02.2.002` · `1.02.2.007` · `1.02.2.003`
pág. **17**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Médica Hospitalaria**

Tema **4.2** · Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH
`1.02.2.002` · `1.02.2.007` · `1.02.2.003`
pág. **18**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Hospitalaria**

Tema **4.3** · Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato
`1.02.2.002` · `1.09.2.006` · `1.02.2.007`
pág. **19**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus**

Tema **4.4** · Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea
`1.02.2.002` · `1.02.2.007`
pág. **20**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Vital**

Tema **4.5** · Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia
`1.02.2.002` · `1.02.2.007`
pág. **21**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y GES Enfermedad Renal Crónica**

Tema **5.1** · Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector
`1.02.1.010` · `1.09.1.014` · `1.02.4.004`
pág. **22**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Retinopatía Diabética (Acceso a tamizaje y fotocoagulación)**

Tema **5.2** · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES
`1.02.1.015` · `6.02.1.023` · `1.02.5.003`
pág. **23**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus (Canasta Integral de Curaciones y Manejo de Pie Diabético)**

Tema **5.3** · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico
`1.02.1.014` · `1.02.1.011` · `1.02.5.001`
pág. **24**

**GES** **Garantía Explícita en Salud: Prevención Secundaria Cardiovascular e Hipertensión Arterial / DM**

Tema **5.4** · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas
`1.02.1.007` · `1.02.3.013` · `1.02.4.021`
pág. **26**

**GES** **Garantía Explícita en Salud: Prevención Cardiovascular / Patología de Urgencia**

Tema **5.5** · Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis
`1.02.2.005` · `1.02.1.007` · `1.02.3.011`
pág. **27**

**Sin garantía GES específica** (2 temas): 2.3 · 5.6. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

# Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

## DÍA 1

5 temas · ★★★


★★★ **3.3** Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado ..... 15
★★★ **1.2** Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS ..... 4
★★★ **1.4** Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas ..... 6
★★★ **2.1** Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL ..... 8
★★★ **2.2** Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas ..... 9


**Practica:** Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 13–16, 18–25, 44–45.

## DÍA 2

4 temas · ★★★


★★★ **2.3** Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 ..... 10
★★★ **3.1** Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio ..... 13
★★★ **3.2** Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis ..... 14
★★★ **1.3** Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) ..... 5


**Practica:** Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 17, 26–27, 37–43.

## DÍA 3

4 temas · ★★★


★★★ **2.4** Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante ..... 11
★★☆ **5.4** Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas ..... 26
★★☆ **5.1** Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector ..... 22
★★☆ **4.2** Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH ..... 18


**Practica:** Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 28–29, 65–68, 74–78, 86–87.

## DÍA 4

4 temas · ★★


★★☆ **3.4** Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate ..... 16
★★☆ **5.3** Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico ..... 24
★★☆ **1.1** Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY ..... 3
★★☆ **4.1** Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) ..... 17


**Practica:** Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 6–12, 46–54, 56–64, 73, 82–85.

## DÍA 5

4 temas · ★★


★★☆ **4.3** Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato ..... 19
★★☆ **5.6** Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria ..... 28
★☆☆ **1.5** Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular ..... 7
★☆☆ **4.4** Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea ..... 20


**Practica:** Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 1–5, 55, 69–72.

## DÍA 6

4 temas · ★


★☆☆ **4.5** Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia ..... 21
★☆☆ **5.2** Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES ..... 23
★☆☆ **5.5** Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis ..... 27
★☆☆ **2.5** Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal ..... 12


**Practica:** Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 30–36, 79–81, 88–90.

## DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 30
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 1.2 · 1.3 · 1.4 · 2.1 · 2.2 · 2.3 · 2.4 · 3.1 · 3.2 · 3.3
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Diabetes Mellitus en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

# Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

## ★★★ Prioridad alta · 10 temas


24 3.3. Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado GES ..... 15
21 1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS GES ..... 4
19 1.4. Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas GES ..... 6
19 2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL GES ..... 8
18 2.2. Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas GES ..... 9
18 2.3. Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 ..... 10
18 3.1. Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio GES ..... 13
18 3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis GES ..... 14
15 1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) GES ..... 5
15 2.4. Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante GES ..... 11


## ★★ Prioridad media · 9 temas


12 5.4. Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas GES ..... 26
9 5.1. Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector GES ..... 22
8 4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH GES ..... 18
6 3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate GES ..... 16
5 5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico GES ..... 24
4 1.1. Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY GES ..... 3
4 4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) GES ..... 17
4 4.3. Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato GES ..... 19
4 5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria ..... 28


## ★ Prioridad baja · 6 temas


3 1.5. Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular GES ..... 7
3 4.4. Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea GES ..... 20
3 4.5. Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia GES ..... 21
1 5.2. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES GES ..... 23
1 5.5. Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis GES ..... 27
0 2.5. Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal GES ..... 12